

Modul Orientasi KADER POSYANDU DALAM PENINGKATAN PELAKSANAAN PROGRAM IMUNISASI



Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Tahun 2023

KEMENKES RI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya buku “Modul Orientasi Kader Posyandu dalam Peningkatan Pelaksanaan Program Imunisasi” telah selesai disusun.

Modul orientasi ini disusun sesuai dengan peran, tugas, dan fungsi Kader Posyandu, serta berdasarkan kebutuhan pengetahuan dan keterampilan yang sebaiknya dimiliki kader. Meningkatkan kapasitas dan integritas kader akan berdampak pada peningkatan kemampuan kader sebagai pencatat sederhana, penggerak masyarakat, dan penyuluh kesehatan guna meningkatkan pelaksanaan Program Imunisasi di Posyandu sehingga dapat meningkatkan capaian cakupan imunisasi di wilayah kerja Kader Posyandu.

Posyandu saat ini telah menjadi Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (LKD/LKK) yang bertugas membantu kepala desa/lurah dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat desa/kelurahan. Imunisasi adalah cara efektif dan efisien dalam mencegah Penyakit-penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I), hal ini tentunya akan berdampak pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di wilayah setempat. Kami berharap pada tahun yang akan datang modul ini dapat diakreditasi sesuai dengan ketentuan peningkatan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku pedoman ini, diucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang maha Esa senantiasa menaungi Langkah kita semua untuk dapat bersama-sama berperan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat.

Jakarta, 17 April 2023

Direktur Jenderal

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,



Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS

KEMENKES RI

TIM PENYUSUN

BUKU MODUL ORIENTASI KADER POSYANDU DALAM PENINGKATAN PELAKSANAAN PROGRAM IMUNISASI

Pembina

Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS (Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)

Pengarah

dr. Prima Yosephine, MKM (Direktur Pengelolaan Imunisasi)
drg. Widyawati, MKM (Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat)

Penulis dan Kontributor Direktorat Pengelolaan Imunisasi

dr. Iqbal Djakaria
dr. Sulistya Widada
dr. Dyan Sawitri
Vivi Voronika, SKM, M.Kes
dr. Tri Setyanti, M.Epid
Reza Isfan Darwis, SKM, MKM
Junghans Sitorus, SKM, M.Kes
Lulu Ariyantheny Dewi, SKM, MPH
Debsy Vonneke Pattilima, SKM, MPH
Agustina Saranga, SKM
Sekar Astrika Fardani, SKM
dr. Novayanti Tangirerung
Diany Lita Sari, SKM, M.Epid

drg. Yulfirda
dr. Cornelia Kelyombar
dr. Eksi Wijayanti, M.Epid
M. Edy Hariyanto, SKM, M.Epid
Gestafiana, SKM, MKM
Rita Yulihane, SKM, M.Epid
Thifal Kiasatina, SKM
Christian I Priyo Boka Wayeni, SKM

Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

Intan Endang S.D, SKM, MKM
Winitra Rahmani Astradiningrat, S.Sos
dr. Marti Rahayu D.K, MKM
Evi Nilawaty, SKM
dr. Ni Made Diah PLD, MKM
Heni Rudiyaniti, SKM, MKM

UNICEF Indonesia

Kenny Peetosutan
Rustini Floranita
Sartini Saman
Sugiarto
Yenny Tju
M. Ruhul Amin

WHO Indonesia

Olivi Silalahi
Musthofa Kamal

CHAI Indonesia

Indah Kusumawati

Editor

dr. Tri Setyanti, M.Epid

Intan Endang S.D, SKM, MKM

Diterbitkan Oleh :

Kementerian Kesehatan RI



Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang
Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya
dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara
mekanis maupun elektronik termasuk fotocop rekaman dan
lain-lain tanpa seijin tertulis dari penerbit

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Tim Penyusun	v
Daftar Isi.....	vii
Materi 1. Pengantar, Definisi dan Peran Kader	1
Materi 2. Pengenalan Program Imunisasi serta PD3I	9
Materi 3. Kader sebagai Pencatat Sederhana	23
Materi 4. Kader sebagai Penggerak Masyarakat.....	41
Materi 5. Kader sebagai Penyuluh.....	53
Langkah-Langkah Pembelajaran (Untuk Fasilitator)	
Materi 2. Pengenalan Program Imunisasi serta PD3I	87
Materi 3. Kader sebagai Pencatat Sederhana	93
Materi 4. Kader sebagai Penggerak.....	101
Materi 5. Kader sebagai Penyuluh.....	113

Modul Orientasi Kader Posyandu



**PENGANTAR:
DEFINISI, PERAN, DAN
FUNGSI KADER**

KEMENKES RI

MATERI 1

PENGANTAR: DEFINISI, FUNGSI, DAN PERAN KADER

A. Definisi Kader

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, diperlukan keterlibatan kader. Definisi kader adalah setiap orang yang dipilih oleh masyarakat dan dilatih untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Seorang kader diharapkan mau dan mampu melaksanakan upaya-upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di bawah pembinaan tenaga pendamping baik pendamping kesehatan maupun pendamping pemberdayaan masyarakat.

Kader memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang meliputi kesehatan ibu, bayi dan balita di mana program imunisasi merupakan salah satunya, sebagai upaya pencegahan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) di masyarakat.

B. Peran dan Fungsi Kader

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan juga menjelaskan bahwa kader memiliki peran-peran yaitu sebagai:

1. Penggerak masyarakat
2. Pengelola Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM);
3. Penyuluh kesehatan kepada masyarakat;
4. Pencatat kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan; dan
5. Pelapor jika ada permasalahan atau kasus kesehatan setempat pada tenaga kesehatan.

Fungsi seorang kader adalah melaksanakan sejumlah kegiatan yang ada di lingkungannya. Kegiatan yang dilakukan sifatnya sederhana akan tetapi juga harus berguna untuk keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam mendukung pencapaian program kesehatan khususnya imunisasi.

C. Tugas Kader di Posyandu

Kader bertugas di pos pelayanan terpadu (Posyandu) dengan kegiatan rutin setiap bulannya adalah melakukan 4 (empat) langkah pelayanan dari 5 (lima) pelayanan di Posyandu.

Pelayanan yang dapat diberikan kader saat hari buka Posyandu yaitu :

1. Pendaftaran,
2. Pencatatan,
3. Penimbangan bayi dan balita, serta
4. Penyuluhan.

Kegiatan rutin Posyandu diselenggarakan dan digerakkan oleh Kader Posyandu dengan bimbingan teknis dari Puskesmas dan sektor terkait.

Sebelum hari buka Posyandu, kader juga memiliki tugas yang sangat penting diantaranya:

1. Menyearluaskan hari buka Posyandu melalui pertemuan warga setempat.
2. Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu.
3. Mempersiapkan sarana Posyandu.
4. Melakukan pembagian tugas antar kader.
5. Berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan petugas lainnya.
6. Mempersiapkan bahan PMT penyuluhan.

Di luar hari buka Posyandu, kader juga masih memiliki tugas-tugas yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan pemutakhiran data sasaran Posyandu
2. Melakukan tindak lanjut terhadap sasaran yang tidak datang saat hari buka Posyandu dan sasaran yang membutuhkan penyuluhan lanjutan
3. Memberitahukan kepada kelompok sasaran agar berkunjung ke Posyandu saat hari buka.
4. Melakukan kunjungan tatap muka ke tokoh masyarakat, dan menghadiri pertemuan rutin kelompok masyarakat atau organisasi keagamaan.

D. Peran Kader dalam Mendukung Program Imunisasi

Dalam hal mendukung pelaksanaan program imunisasi, selain melaksanakan 4 pelayanan saat hari buka Posyandu yang berhubungan dengan kegiatan pemberian imunisasi, kader juga perlu melakukan kegiatan-kegiatan di lingkungan/wilayah binaannya, yaitu:

- a) Merencanakan dan mengelola kegiatan pelayanan imunisasi di Posyandu, bersama masyarakat dan pendamping teknis (petugas puskesmas, petugas pemberdayaan masyarakat lainnya, dan No. PKK/kader PKK).
- b) Melakukan pendataan riil data sasaran program imunisasi,
- c) Bersama petugas kesehatan melaksanakan upaya pelacakan bayi dan baduta yang belum atau tidak lengkap status imunisasinya secara rutin setiap bulan dan melaksanakan tindak lanjut upaya pelacakan tersebut,
- d) Melakukan penyuluhan/menyampaikan informasi kepada orang tua dan keluarga dengan melakukan komunikasi antar pribadi mengenai manfaat dan pentingnya imunisasi bagi bayi dan anak serta mengenali Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I).
- e) Menyampaikan informasi dan memotivasi perangkat desa/kelurahan serta tokoh masyarakat setempat untuk mendukung program imunisasi serta memastikan seluruh bayi dan anak mendapatkan imunisasi rutin lengkap sesuai usia dengan memanfaatkan pelayanan imunisasi di Posyandu, puskesmas maupun fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

E. Integritas Kader

Dalam menjalankan peran dan tugasnya, seorang kader diharapkan mempunyai integritas tinggi. Kader yang berintegritas tinggi adalah yang memahami cara untuk mengenal dan mengetahui mutu serta kemampuan dirinya terletak di bidang apa dan juga akan mengetahui sifat yang bisa membawa kewibawaan dan melahirkan kejujuran, sehingga mampu bekerja maksimal untuk menghasilkan karya

terbaiknya dalam membantu penyelesaian masalah kesehatan dalam hal ini program imunisasi.

Beberapa tips dalam membangun integritas diri, yaitu:

- a) Berpikir positif
- b) Selalu menepati janji
- c) Memegang teguh komitmen dan bertanggungjawab
- d) Satu kata, satu perbuatan
- e) Menghargai waktu
- f) Menjaga prinsip dan nilai-nilai yang diyakini
- g) Lakukan sesuatu secara benar walau sulit
- h) Bersikap jujur dan sopan terhadap diri sendiri dan orang lain
- i) Berusaha memperbaiki kesalahan

F. Tujuan dan Sasaran Modul Orientasi Kader

Tujuan modul orientasi kader adalah sebagai bahan acuan dalam proses pembelajaran dan penguatan peran dan fungsi kader dalam mendukung program imunisasi. Sebagai sasarannya, modul ini dapat digunakan dalam sosialisasi, *workshop* dan orientasi kader yang diselenggarakan oleh Puskesmas, Pengurus Desa/Kelurahan, Pengurus Kecamatan dan pihak-pihak lain yang terkait. Dengan adanya modul ini, diharapkan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas kader dalam hal imunisasi memiliki muatan yang ter standarisasi dan mencakup seluruh peran yang diharapkan dari kader masyarakat.

KEMENKES RI

Modul Orientasi Kader Posyandu



**PENGENALAN PROGRAM
IMUNISASI SERTA PENYAKIT
YANG DAPAT DICEGAH
DENGAN IMUNISASI (PD3I)**

KEMENKES RI

MATERI 2

PENGENALAN PROGRAM IMUNISASI SERTA PENYAKIT-PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I)

A. Pendahuluan

Imunisasi adalah upaya aktif untuk menimbulkan kekebalan khusus dalam tubuh seseorang yang efektif mencegah penularan penyakit tertentu dengan cara memberikan vaksin. Penyakit tertentu tersebut dikenal sebagai Penyakit-penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I).

Terdapat beberapa PD3I antara lain hepatitis B, tuberkulosis, polio, difteri, pertusis (batuk rejan), tetanus, campak, rubela, pnemonia (radang paru), meningitis, kanker leher rahim yang disebabkan oleh infeksi *Human Papilloma Virus* (HPV), ensefalitis (radang otak) akibat infeksi virus *Japanese encephalitis* (JE), dan diare yang disebabkan oleh infeksi *Rotavirus*.

Vaksin yang digunakan dalam program imunisasi nasional sudah diakui oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan lulus uji Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Vaksin-vaksin ini aman dan efektif untuk mencegah kesakitan, kecacatan dan kematian karena PD3I. Demam ringan, ruam merah, bengkak ringan dan nyeri di tempat suntikan setelah imunisasi adalah reaksi normal yang akan menghilang dalam 2-3 hari. Kejadian ikutan pasca imunisasi yang serius sangat jarang terjadi.

B. Jadwal Pemberian Imunisasi Rutin

Imunisasi dasar harus diberikan pada bayi usia 0-11 bulan. Untuk mempertahankan perlindungan terhadap penyakit, maka imunisasi

lanjutan harus diberikan pada anak usia kurang dari 2 tahun (baduta) dan anak usia sekolah dasar/madrasah/ sederajat melalui program Bulan Imunisasi Anak Usia Sekolah (BIAS).



Gambar 1. Jadwal Pemberian Imunisasi Rutin bagi Bayi dan Baduta serta Anak Usia Sekolah Dasar/Madrasah/Sederajat

Imunisasi rutin diberikan sesuai dengan jadwal untuk mendapatkan kekebalan optimal terhadap PD3I. Apabila bayi terlambat untuk mendapatkan imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan, maka kader diharapkan bisa mengingatkan pengasuh agar status imunisasi bayi dilengkapi dan melaporkan kepada bidan desa atau petugas imunisasi puskesmas setempat. Imunisasi Hepatitis B untuk bayi baru lahir (HB 0) hanya dapat diberikan dalam waktu maksimal 24 jam setelah

dilahirkan, sedangkan imunisasi BCG hanya dapat diberikan sampai usia maksimal 1 tahun.

Anak dengan imunisasi tidak lengkap rentan tertular penyakit, dapat menularkan ke anak atau orang lain di sekitarnya, serta bisa mengalami kecacatan dan bahkan kematian.

Imunisasi bagi Wanita Usia Subur (WUS)

Pada program imunisasi nasional, imunisasi tetanus diberikan bagi WUS usia 15-39 tahun, termasuk ibu hamil setelah dilakukan skrining (penapisan) oleh petugas imunisasi. Program ini dilakukan untuk mencegah penyakit tetanus pada ibu dan bayi baru lahir.

Tabel 3. Penapisan Status Imunisasi Tetanus dan Pemberian Imunisasi Lanjutan Td Pada WUS

Status Imunisasi	Interval Minimal Pemberian	Masa Perlindungan
T1	-	-
T2	4 minggu setelah T1	3 tahun
T3	6 bulan setelah T2	5 tahun
T4	1 tahun setelah T3	10 tahun
T5	1 tahun setelah T4	Lebih dari 25 tahun

Catatan:

- Sebelum imunisasi, dilakukan penentuan status imunisasi T (penapisan) terlebih dahulu, terutama pada saat pelayanan antenatal.
- Imunisasi Td tidak perlu diberikan apabila sasaran sudah lengkap status T5 yang harus dibuktikan dengan buku Kesehatan Ibu dan Anak, kohort, rekam medis, dan/atau berdasarkan ingatan.

C. Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)

Beberapa PD3I yang saat ini masuk dalam program imunisasi adalah :

1. Penyakit Polio

Penyakit saraf yang menyebabkan kelumpuhan disebabkan oleh virus Polio. **Gejala:** lumpuh pada anggota gerak yang sifatnya layu (lemas), terjadi mendadak, kadang disertai demam. **Penularan:** melalui tinja atau air yang tercemar tinja yang mengandung virus Polio. **Komplikasi:** lumpuh permanen, kematian jika kelumpuhan mengenai saraf pernafasan.

Laporkan ke Bidan Desa/Puskesmas/Petugas Kesehatan terdekat: jika ada anak umur di bawah 15 tahun dengan gejala lumpuh layu (lemas) yang terjadi secara mendadak.



Gambar 1: ilustrasi Penderita Polio

2. Campak

Penyakit menular disebabkan oleh virus campak. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebabkan keparahan terutama pada anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi dan gizi kurang/gizi buruk. **Penularan:** percikan ludah (batuk/bersin/muntah). **Gejala:** demam, bintik-bintik kemerahan pada kulit, batuk- pilek, dan mata merah. **Komplikasi:** diare berat, infeksi paru-paru berat dan kematian.

Laporkan ke Bidan Desa/Puskesmas/Petugas Kesehatan terdekat: jika ada warga (anak-anak maupun orang dewasa) dengan gejala demam dan disertai ruam bintik-bintik merah (perhatian khusus untuk anak-anak yang mengalami kurang gizi).



Gambar 2: ilustrasi Penderita Campak

3. Difteri

Difteri adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri difteri yang dapat menyebabkan kematian. **Penularan:** percikan ludah (batuk/bersin/muntah). **Gejala:** nyeri menelan, demam, muncul selaput warna putih di dalam tenggorokan. **Komplikasi:** sesak nafas, gangguan jantung, dan kematian.

Laporkan ke Bidan Desa/Puskesmas/Petugas Kesehatan terdekat: orang dengan gejala nyeri menelan dan demam.



Gambar 3: ilustrasi Gejala Difteri

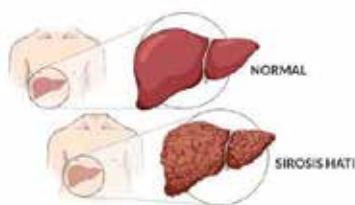
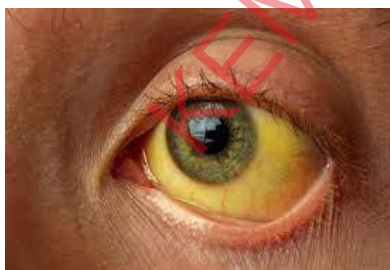
4. Hepatitis B

Hepatitis B (penyakit kuning) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis B yang merusak hati. **Penularan:** darah, suntikan yang tidak bersih/steril, hubungan seksual yang tidak aman dan penularan dari ibu yang terinfeksi Hepatitis B ke bayi.

Gejala: badan lemas, mual/muntah, mata dan kulit kekuningan, air kencing berwarna gelap (seperti air teh), warna tinja pucat.

Komplikasi: pengerasan hati, kanker hati dan kematian.

Laporkan ke Bidan Desa/Puskesmas/Petugas Kesehatan terdekat: jika ditemukan orang dengan gejala kekuningan di mata atau kulit, mual muntah dan badan lemas.



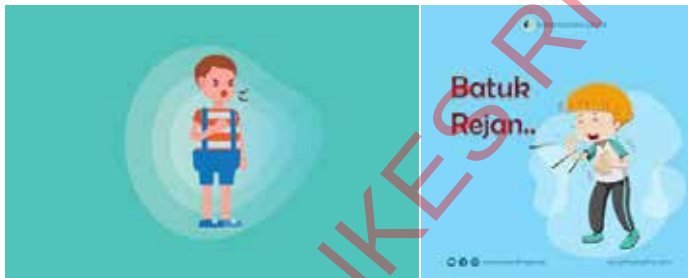
Gambar 4: ilustrasi Penderita Hepatitis B

5. Pertusis

Pertusis atau batuk rejan yang disebabkan oleh bakteri. **Penularan:** percikan ludah (batuk/bersin/muntah) dengan penularan tinggi.

Gejala: batuk lama (>2 minggu), batuk yang diikuti dengan muntah, mata merah dan demam. **Komplikasi:** infeksi paru berat yang menyebabkan kematian.

Laporkan ke Bidan Desa/Puskesmas/Petugas Kesehatan terdekat: jika ditemukan orang dengan batuk berhari-hari dan tidak sembuh.

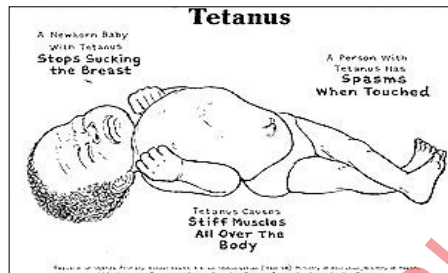


Gambar 5: ilustrasi Penderita Pertusis

6. Tetanus

Penyakit yang disebabkan oleh bakteri tetanus yang menyerang sistem saraf. **Penularan:** bakteri masuk melalui luka yang dalam atau pada saat memotong/merawat tali pusat dengan alat yang tidak steril. **Gejala:** kejang, kaku otot (perut, rahang, leher, dan otot lainnya), demam tinggi, pada bayi tidak bisa menetek/menyusu (awalnya bisa menyusu/menetek). **Komplikasi:** sering terjadi kematian. **Laporkan:** jika ada bayi baru lahir kurang dari 1 bulan yang memiliki gejala (mulut mencucu, berhenti menetek, kejang/kaku).

Laporkan ke Bidan Desa/Puskesmas/Petugas Kesehatan terdekat: jika ditemukan bayi dengan demam, kejang atau tidak mau menetek.



Gambar 6: ilustrasi Penderita Tetanus

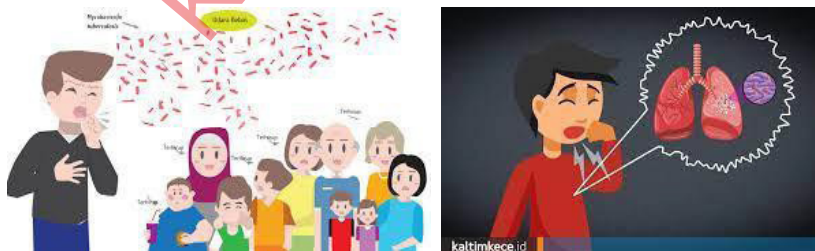
7. Tuberkulosis (batuk darah)

Penyakit paru menular disebabkan oleh bakteri tuberkulosis.

Penularan: percikan ludah yang keluar saat batuk/bersin/muntah.

Gejala: demam, keluar keringat malam, lemas, batuk parah dan disertai darah, sesak nafas, nyeri dada. Bakteri ini juga dapat menyerang organ selain paru-paru seperti tulang, kulit, dan otak. **Komplikasi:** kematian.

Laporkan ke Bidan Desa/Puskesmas/Petugas Kesehatan terdekat: jika ada orang (anak-anak/dewasa) dengan batuk >2 minggu dan berat badan menurun.



Gambar 7: Ilustrasi Penderita Tuberkulosis

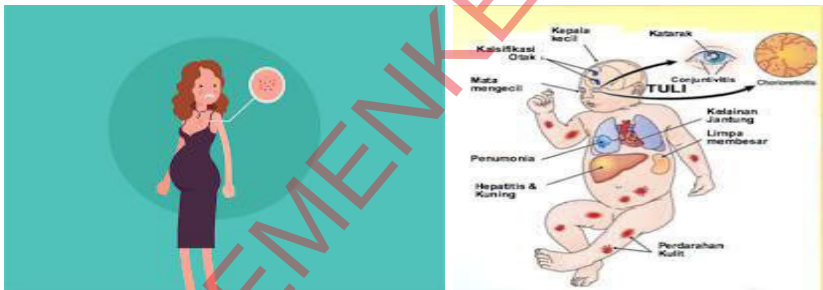
8. Rubela

Rubela atau Campak Jerman disebabkan oleh virus Rubela.

Penularan: percikan ludah yang dikeluarkan penderita melalui batuk/bersin/muntah. **Gejala:** demam dan ruam kulit (bintik-bintik kemerahan). **Komplikasi:** Virus rubela paling berbahaya

jika mengenai ibu hamil (terutama pada saat usia kehamilan kurang dari 3 bulan) karena dapat menyebabkan keguguran, dan jika anaknya lahir dapat menyebabkan cacat bawaan (Sindrom Kongenital Rubela) seperti bocor jantung, kebutaan, tuli (gangguan pendengaran), dan kerusakan pada otak.

Laporkan ke Bidan Desa/Puskesmas/Petugas Kesehatan terdekat: jika ada warga (anak-anak maupun orang dewasa) dengan gejala demam dan ruam bintik- bintik merah



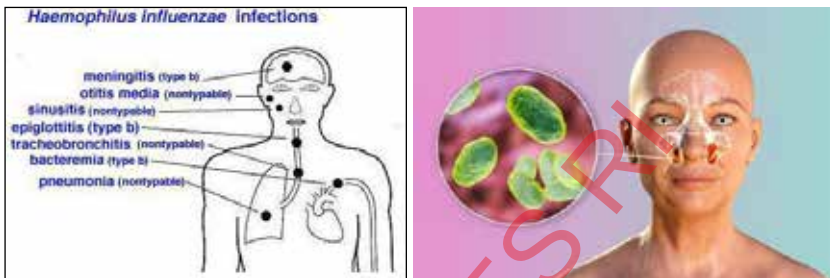
Gambar 8: Ilustrasi Sindrom Kongenital Rubela

9. *Hemofilus influenza* tipe b

Penyakit yang disebabkan oleh virus Influenza dan dapat menyebabkan infeksi pada otak, paru-paru, persendian atau infeksi pada jaringan tubuh. **Penularan:** percikan ludah yang keluar saat batuk/bersin/muntah. **Gejala:** tergantung organ tubuh yang diserang, biasanya diawali dengan demam. Jika menyerang otak maka akan menyebabkan kaku pada leher, kehilangan

kesadaran, sakit kepala berat. Jika menyerang paru-paru maka akan menyebabkan sesak nafas dan nyeri dada. **Komplikasi:** gejala menetap, gangguan otak, kematian.

Laporkan ke Bidan Desa/Puskesmas/Petugas Kesehatan terdekat: jika ditemukan orang dengan gejala demam, leher kaku dan sakit kepala berat

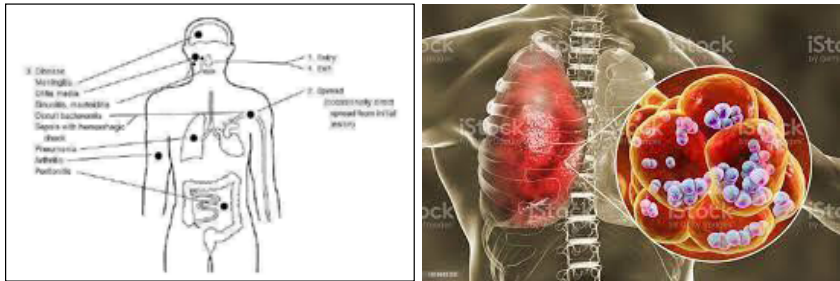


Gambar 9: Ilustrasi Gejala *Haemophilus influenza*

10. Pneumokokus

Bakteri yang menyebabkan infeksi paru-paru berat (infeksi saluran pernafasan berat) atau pneumonia, yang merupakan penyebab kematian utama pada anak-anak. **Penularan:** percikan ludah yang keluar saat bersin/batuk/muntah. **Gejala:** demam, sesak nafas, serta dapat menyerang organ lain seperti otak dan sistem/saluran pendengaran dengan gejala salah satunya adalah keluar cairan seperti nanah dari telinga. **Komplikasi:** kematian akibat pneumonia, jika menyebar ke otak maka akan menyebabkan infeksi otak (hilang kesadaran, demam tinggi, kejang-kejang).

Laporkan ke Bidan Desa/Puskesmas/Petugas Kesehatan terdekat: jika ditemukan orang dengan demam, sesak nafas atau keluar cairan dari telinga.



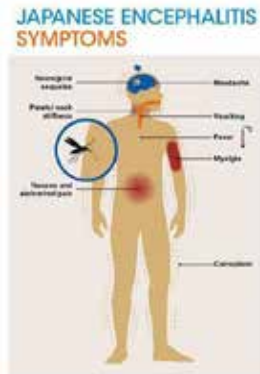
Gambar 10: Ilustrasi Kumpulan Gejala Pneumokokus

11. Japanese encephalitis (JE)

Penyakit yang menyerang otak yang disebabkan oleh virus.

Penularan: dari babi/burung/kelelawar yang mengandung virus JE melalui gigitan nyamuk. **Gejala:** demam, nyeri kepala, muntah, dan menggigil. **Komplikasi:** penurunan kesadaran, gangguan otak permanen meskipun sudah dinyatakan sembuh, dan kematian pada beberapa kasus yang tidak segera ditangani.

Laporkan ke Bidan Desa/Puskesmas/Petugas Kesehatan terdekat: jika ditemukan orang dengan demam, nyeri kepala dan muntah.



Gambar 11: Ilustrasi Kumpulan Gejala *Japanese encephalitis*

12. Kanker Leher Rahim

Kanker yang disebabkan oleh virus HPV. **Penularan:** melalui hubungan seksual dengan orang yang terinfeksi HPV. **Gejala:** gejala awal adalah perdarahan vagina, sakit pada daerah pinggang dan panggul, kutil pada area kelamin. **Komplikasi:** jika infeksi berlanjut dan tidak ditangani, maka dapat menyebabkan kanker leher rahim.

Laporkan ke Bidan Desa/Puskesmas/Petugas Kesehatan terdekat: jika ditemukan orang dengan nyeri di pinggang dan



Gambar 12: Ilustrasi Gejala Kanker Leher Rahim

Modul Orientasi Kader Posyandu



KADER SEBAGAI PENCATAT SEDERHANA

KEMENKES RI

MATERI 3

KADER SEBAGAI PENCATAT SEDERHANA

A. Manfaat Pencatatan dalam Pelaksanaan Program Imunisasi dan Peran Kader Sebagai Pencatat Sederhana

Pencatatan dan pelaporan dalam penyelenggaraan program imunisasi sangat penting dilakukan di semua tingkat administrasi guna mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan maupun evaluasi. Hasil pencatatan yang dilakukan oleh setiap unit yang melakukan kegiatan imunisasi, mulai dari posyandu, puskesmas, puskesmas pembantu, praktik mandiri bidan, dokter praktik, rumah sakit, klinik dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, baik pemerintah maupun swasta, dilaporkan secara berjenjang sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Kader memiliki salah satu tugas yaitu sebagai pencatat sederhana. Pencatatan sederhana meliputi pencatatan/register sesuai Sistem Informasi Posyandu (SIP) dan dilakukan dengan mengacu pada formulir standar yang ditetapkan. Kegiatan pencatatan dilaksanakan untuk mendukung pengolahan data yang akan memberikan manfaat yaitu:

1. Mendapatkan gambaran umum kondisi cakupan imunisasi bayi dan baduta di wilayah binaannya.
2. Sebagai bahan untuk menyusun rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh kader
3. Sebagai bahan untuk melakukan penyuluhan sederhana pada keluarga sesuai permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing keluarga

4. Sebagai bahan untuk menggerakkan masyarakat dan berkoordinasi dengan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) terkait dengan program imunisasi dan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)
5. Mengetahui perkembangan kondisi kesehatan keluarga di wilayah binaan.

B. Pendataan Riil Sasaran Program Imunisasi

Kader berperan penting dalam mendukung upaya pendataan sasaran program imunisasi yang dilakukan oleh petugas puskesmas. Data riil sasaran di tiap wilayah bermanfaat untuk menjadi pembanding data sasaran, untuk memastikan seluruh sasaran betul-betul terjangkau dan mendapatkan imunisasi sesuai usia. Kelompok usia sasaran yang perlu didata yaitu bayi, baduta, anak usia sekolah dasar/ sederajat kelas 1 (7 tahun), 2 (8 tahun) dan 5 (11 tahun), serta kelompok usia lain sesuai kebutuhan program.

Mekanisme pendataan riil sasaran program imunisasi yaitu sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Ketua Kelompok Dasa wisma di wilayah kerja Posyandu atau ketua RT/RW serta Lurah atau Kepala Desa setempat untuk melakukan pendataan riil warga yang berdomisili dan masuk ke dalam kelompok usia sasaran program imunisasi
2. Membantu menyiapkan buku catatan/register imunisasi sesuai Sistem Informasi Posyandu (SIP). Bawa serta buku KIA baru untuk diberikan kepada anak-anak yang belum memilikinya
3. Data sasaran riil akan diambil oleh petugas kesehatan setiap kegiatan Posyandu.

4. Data sasaran anak usia sekolah disampaikan satu bulan sebelum pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS).

C. Pencatatan Hasil Layanan Imunisasi di Posyandu

Pada hari buka Posyandu, kader dapat mengisi register Posyandu dan membantu tenaga kesehatan dalam pencatatan buku KIA.

1. Pencatatan pada Buku KIA

- Pencatatan pada Buku KIA dilakukan setelah bayi/baduta di imunisasi.
- Isi dengan tanggal, bulan dan tahun pemberian imunisasi untuk setiap jenis imunisasi.
- Pencatatan harus dilakukan segera pada saat pelayanan, tidak ditunda dan diisi secara lengkap sesuai kolom yang tersedia.

PELAYANAN IMUNISASI

UMUR	BULAN																	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	18	23	23-59		
Jenis Vaksin	Tanggal Pemberian dan Paraf Petugas																	
Hepatitis B (<24 Jam)																		
No Batch:																		
BCG																		
No Batch:																		
Polio tetes 1																		
No Batch:																		
DPT-HB-Hib 1																		
No Batch:																		
Polio Tetes 2																		
No Batch:																		
Rota Virus (RV)1*																		
No Batch:																		
PCV 1																		
No Batch:																		
DPT-HB-Hib 2																		
No Batch:																		
Polio Tetes 3																		
No Batch:																		
Rota Virus (RV)2 *																		
No Batch:																		
PCV2																		
No Batch:																		
DPT-HB-Hib 3																		
No Batch:																		
Polio Tetes 4																		
No Batch:																		
Polio Suntik (IPV) 1																		
No Batch:																		
Rota Virus (RV) 3*																		
No Batch:																		
Campak - Rubella (MR)																		
No Batch:																		
Polio Suntik (IPV) 2*																		
No Batch:																		
*Japanese Encephalitis (JE)																		
No Batch:																		
PCV3																		
No Batch:																		
DPT-HB-Hib Lanjutan.																		
No Batch:																		
Campak - Rubella (MR) Lanjutan																		
No Batch:																		

* Imunisasi JE baru diberikan di beberapa provinsi dan kabupaten/ kota percontohan

Keterangan:

- Usia Tepat Pemberian Imunisasi
- Usia yang masih diperbolehkan untuk melengkapi Imunisasi Bayi dan Baduta (Bawah Dua Tahun)
- Usia Pemberian Imunisasi bayi dan baduta yang belum lengkap (Imunisasi Kejar)
- Usia yang tidak diperbolehkan untuk pemberian Imunisasi

Gambar 13. Pencatatan Pelayanan Imunisasi pada Buku KIA tahun 2022

2. Pencatatan pada Register Posyandu

- Isi data pada setiap kolom register posyandu dengan identitas anak, orang tua dan alamat. Kader dapat menambahkan data tersebut pada register posyandu bagi yang belum terdata.
- Pada bagian imunisasi diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pemberian imunisasi untuk setiap jenis imunisasi, termasuk kolom pencatatan status imunisasi dasar lengkap.
- Pencatatan harus dilakukan segera pada saat pelayanan, tidak ditunda dan diisi.

3. Pencatatan Data Riwayat Imunisasi

Penginputan Imunisasi rutin di aplikasi ASIK baru diimplementasikan sejak 1 Januari 2023. Data Riwayat Imunisasi anak yang sudah didapat oleh sasaran Imunisasi sebelumnya (riwayat imunisasi dasar/bayi, imunisasi lanjutan/baduta, BIAS, dan WUS, serta data riwayat imunisasi tambahan) harus diinput ke dalam aplikasi ASIK agar status Imunisasi anak dapat tercatat menjadi suatu kohort data imunisasi di dalam *database* ASIK. Melalui data kohort imunisasi ini, maka data imunisasi anak sejak dari lahir hingga WUS dapat tercatat seluruhnya, dan status Imunisasi dasar lengkap (IDL), status Imunisasi baduta lengkap, status Imunisasi BIAS lengkap, status Imunisasi WUS lengkap dan status Imunisasi rutin lengkap (IRL) dapat ditentukan melalui *database* ASIK.

Penginputan data riwayat imunisasi anak melalui aplikasi ASIK dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan atau kader posyandu yang telah dilatih serta diberikan akses oleh pengelola imunisasi puskesmas. Khusus untuk pencatatan riwayat data imunisasi BIAS dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan atau guru UKS yang telah dilatih dan diberikan akses oleh pengelola imunisasi puskesmas.

- Penginputan Data Riwayat Imunisasi Rutin Bayi, Baduta, BIAS, dan WUS Input data Riwayat Imunisasi rutin bayi dilaksanakan menggunakan aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) dengan menggunakan *handphone* android.
- Penginputan data riwayat imunisasi dilakukan dengan mengikuti fitur pencatatan data riwayat imunisasi seperti ditampilkan di bawah ini:



D. Membantu tenaga Kesehatan dalam pelacakan dan Kunjungan ke Ketua Kelompok Dasa Wisma untuk mendata Bayi dan Baduta yang Belum/Tidak Lengkap Status Imunisasinya

Untuk mencegah peningkatan jumlah anak belum/tidak lengkap status imunisasinya perlu dilakukan kegiatan pelacakan bayi dan baduta oleh petugas kesehatan Puskesmas bersama-sama dengan kader. Setelah mengidentifikasi anak-anak yang belum diimunisasi atau tidak lengkap imunisasinya, maka lakukan penyuluhan, komunikasi antar pribadi dan pemberian motivasi, ajakan untuk

imunisasi.

Terdapat beberapa **pilihan cara** dan alat bantu yang dapat digunakan dalam kegiatan pelacakan ini dimana kader dapat turut berperan yaitu:

1. **My Village My Home (MVMH)**

- a) *My Village My Home (MVMH)* berupa *banner* yang berisi nama sasaran/anak, tanggal lahir, jenis kelamin, nama orang tua, alamat, No. telepon/HP orang tua, tanggal pemberian imunisasi sesuai jenis antigen, dan kolom keterangan.
- b) *Banner* MVMH dipasang di posyandu, sementara untuk posyandu yang tidak permanen, *banner* MVMH disimpan oleh kader dan dipasang menjelang pelayanan.
- c) *Banner* MVMH dapat menggunakan nama lain menyesuaikan dengan bahasa daerah,
- d) *Banner* MVMH ini dimanfaatkan oleh petugas kesehatan, bidan desa, kader posyandu, orang tua dan masyarakat untuk memantau status imunisasi anak-anak di wilayah posyandu tersebut.
- e) Keuntungan memakai MVMH adalah petugas, kader, ibu, masyarakat, perangkat desa/kelurahan dapat membaca dan kemudian saling mengingatkan bila sasaran tidak datang pada jadwal yang telah ditentukan.
- f) Langkah-langkah penggunaan MVMH, kader bekerja sama dengan petugas kesehatan untuk:
 - Menyiapkan *banner* MVMH dan kohort/register imunisasi posyandu

- Menuliskan data sasaran bayi dan baduta yang ada di kohort/register imunisasi ke *banner* MVMH
- Mencatat nama bayi, nama orang tua, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, No. telepon/HP pada kolom yang tersedia dari baris paling atas dilanjutkan baris di bawahnya
- Untuk kolom imunisasi catat tanggal pemberian imunisasi yang sudah diberikan pada kolom jenis antigen yang sesuai
- Catat daftar anak yang akan diimunisasi pada hari pelayanan imunisasi
- Daftar anak imunisasi diumumkan melalui WA/SMS/ pengumuman mesjid, gereja, dan tempat ibadah/ umum lainnya
- Pada hari pelayanan, catat pemberian imunisasi (tanggal dan bulan) pada kolom imunisasi sesuai jenis antigen/imunisasi yang diberikan pada MVMH
- Kader dapat membantu menuliskan tanggal imunisasi anak pada *banner* MVMH. Orang tua juga dapat menuliskan tanggal anaknya mendapatkan imunisasi pada *banner* MVMH sehingga orang tua dapat turut aktif berpartisipasi dalam memantau status imunisasi
- Jika sudah mendapatkan semua antigen pada masa bayi, beri tanda bintang (*) pada kolom IDL.
- Jika sudah mendapatkan semua antigen pada masa baduta, beri tanda bintang (*) pada kolom keterangan

- Beri tanda huruf "P" bagi anak yang pindah domisili pada kolom keterangan

Bagi anak yang tidak datang sesuai jadwal maka petugas kesehatan bersama kader mencari informasi dan melaksanakan pelacakan.



Gambar 14. Contoh *Banner My Village My Home (MVMH)*

2. Kantong Imunisasi

- Kantong imunisasi adalah kantong yang terbuat dari kain atau kertas tebal yang berisi nama-nama sasaran. Cara mempergunakan kantong imunisasi pada prinsipnya sama dengan kotak pengingat, kelebihan kantong imunisasi lebih tahan lama, tidak mengambil tempat (digantung) dan lebih mudah terlihat. Kader bersama petugas dapat membuat kantong imunisasi di masing-masing posyandu.
- Langkah-langkah penggunaan kantong imunisasi:
 - Buat 12 kantong imunisasi pada selembur kain atau kertas tebal yang setiap kantong dapat menampung

seri kartu menurut 12 bulan dalam setahun

- Buat kartu pengingat sejumlah sasaran imunisasi bayi dan baduta dengan mencantumkan antara lain: nama, tanggal lahir anak, nama orang tua, alamat, No. telepon/HP, dan jadwal imunisasi per antigen
- Siapkan buku register imunisasi untuk posyandu setempat
- Catat nama, tanggal lahir anak, nama orang tua, alamat, No. telepon/HP, tanggal dan jenis antigen yang sudah diberikan, serta tanggal dan jenis antigen berikutnya
- Letakkan kartu pengingat ke dalam kantong imunisasi sesuai bulan pelaksanaan jadwal imunisasi berikutnya
- Kader mengingatkan orang tua anak yang akan mendapatkan imunisasi pada hari buka posyandu berikutnya
- Pada hari pelayanan, kader mengambil kantong imunisasi yang telah berisi kartu pengingat sesuai bulan pelaksanaan posyandu
- Catat tanggal pelayanan sesuai jenis antigen di register imunisasi dan buku KIA serta kartu pengingat segera setelah pelayanan
- Letakkan kartu pengingat ke dalam kantong imunisasi bulanan sesuai dengan jadwal imunisasi berikutnya
- Setelah pelayanan, kartu pengingat yang masih ada dalam kantong imunisasi adalah anak yang tidak

datang mendapatkan pelayanan imunisasi, selanjutnya dicatat di dalam format pelacakan

- Letakkan kartu pengingat anak yang tidak datang pada bulan berikutnya



Gambar 15. Contoh Kantong Imunisasi

Selain itu dapat juga dikembangkan metode lain menggunakan SMS/WhatsApp Reminder.

SMS/WhatsApp Reminder

- a) Penggunaan metode SMS/WhatsApp untuk mengingatkan orang tua/ibu/pengasuh anak untuk membawa anaknya ke posyandu mendapatkan imunisasi.
- b) Langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:
 - Catat nama orang tua anak/pengasuh lengkap dengan nomor HP/WA
 - Masukkan ke dalam daftar kontak HP petugas/kader
 - Berdasarkan register posyandu, kader mengingatkan orang tua anak/pengasuh yang akan mendapatkan imunisasi pada

hari buka posyandu berikutnya melalui SMS/WA.

- Catat tanggal pelayanan imunisasi sesuai jenis antigen di register posyandu dan buku KIA segera setelah pelayanan dan buatlah pengingat sesuai jadwal imunisasi berikutnya
- Bayi atau baduta yang tidak datang dicatat di dalam format pelacakan (Tabel 4).

Tabel 4. Format Pelacakan

E. Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Berbasis Masyarakat

Surveilans kesehatan berbasis masyarakat merupakan kegiatan pemantauan secara terus menerus terhadap penyebab terjadinya masalah kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Melalui kegiatan ini, diharapkan apabila terdapat permasalahan kesehatan di masyarakat dapat dilaporkan secara cepat. Apabila terdapat dugaan penyakit PD3I maka kader Posyandu bersama ketua RT/ RW melapor ke Bidan Desa/Petugas Kesehatan di Puskesmas.

Kader Posyandu memiliki peran penting membantu bidan desa/petugas kesehatan dalam melaksanakan surveilans kesehatan

berbasis masyarakat. Pelaksanaan surveilans kesehatan berbasis masyarakat oleh kader posyandu dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan pelaksanaan kegiatan:
 - a. Mengidentifikasi kelengkapan data sasaran yang meliputi nama kepala keluarga, nama anggota keluarga yang menjadi sasaran, alamat, nomor kontak yang dapat dihubungi.
 - b. Menetapkan permasalahan yang akan disurvei. Penetapan masalah menggunakan data pencatatan imunisasi di Posyandu. Contoh: Cakupan pemberian imunisasi hanya 54% maka masalah ini akan dicari penyebabnya mengapa rendah dan bagaimana penyelesaiannya.
 - c. Membuat instrumen sederhana dalam bentuk Ceklis agar mudah diisi
 - d. Menetapkan wilayah dan membagi rumah sasaran yang akan disurvei sesuai dengan wilayah kerja kader Posyandu.
2. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu saat hari buka Posyandu atau di luar hari buka Posyandu dengan mengikuti protokol kesehatan dalam adaptasi kebiasaan baru.
3. Melengkapi tabel instrumen surveilans kesehatan berbasis masyarakat dan data hasil survei ini dapat diambil oleh petugas kesehatan dan petugas lintas sektor terkait yang membutuhkan serta ke Pemerintah

Tabel 5. Instrumen Surveilans Kesehatan Berbasis Masyarakat di Wilayah Kerja Posyandu..... Desa/Kelurahan.....

I	
Wilayah Kerja Posyandu	Nama Kader

II	
Karakteristik Keluarga	
Nama Kepala Keluarga	
Alamat	
Nomor HP	

Jumlah Anggota Keluarga				
Ayah	Ibu bayi/ibu baduta	Anak bayi	Anak baduta	Anggota keluarga lainnya

III		Ya	Tidak	Keterangan	Rekap/Kesimpulan
Pertanyaan Keluarga					
1. Ibu bayi/baduta rutin membawa anaknya imunisasi ke Posyandu				Bila jawaban tidak, isi dengan alasan	
2. Imunisasi Dasar (jenis imunisasi dapat ditambahkan):					
▶ HB0				Isi dengan tanggal pemberian imunisasi	
▶ BCG					
▶ PCV					
▶ DPT-HB-Hib 3					
▶ Polio Tetes 4					
▶ IPV (Polio Suntik)					
▶ Rotavirus 3					
▶ Campak Rubela 1					
▶					

Pertanyaan Keluarga	Ya	Tidak	Keterangan	Rekap/Kesimpulan
3. Imunisasi Lanjutan pada baduta				
▶ DPT-HB-Hib 4			Isi dengan tanggal pemberian imunisasi	
▶ Campak Rubela 2				
4. Apakah bayi/baduta mengalami keluhan setelah pemberian imunisasi?				
			Isi dengan tanggal dimulainya keluhan dan tuliskan apa saja keluhananya	
5. Apakah ada anggota keluarga yang saat ini sedang mengalami sakit?				
▶ Lumpuh layu mendadak usia kurang dari 15 tahun			Isi dengan informasi siapa anggota keluarga tersebut dan apa saja gejala/keluhan yang dialami Kader melaporkan dan bila diperlukan mendampingi ke puskesmas	
▶ Demam dan bercak kemerahan di kulit				
▶ Demam dan sakit menelan				
▶ Batuk terus menerus				
▶ Bayi baru lahir yang tidak bisa menyusu/kesulitan minum (ada kejang apabila ada rangsangan cahaya, suara, dan sentuhan)				
IV				
Hasil Pemantauan				

Melalui kegiatan surveilans kesehatan berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh kader ini, juga diharapkan dapat mendeteksi kasus-kasus PD3I sedini mungkin. Beberapa penyakit/gejala penyakit yang perlu menjadi perhatian dan harus segera dilaporkan ke petugas kesehatan yaitu:

1. Lumpuh layu mendadak pada anak usia kurang dari 15 tahun.
2. Demam dan bercak kemerahan di kulit.
3. Demam dan sakit menelan.
4. Batuk terus menerus.
5. Bayi baru lahir yang tidak bisa menyusu/kesulitan minum. (ada kejang apabila ada rangsangan cahaya, suara dan sentuhan)

Semua penyakit di atas apabila dilaporkan sedini mungkin dapat mencegah terjadinya KLB PD3I dengan respons tatalaksana kasus yang cepat sehingga dapat meminimalisir kecacatan dan kematian akibat PD3I.

Modul Orientasi Kader Posyandu



**KADER SEBAGAI
PENGGERAK MASYARAKAT**

KEMENKES RI

MATERI 4

KADER SEBAGAI PENGGERAK MASYARAKAT

A. Peran Kader sebagai Penggerak Program Imunisasi

Posyandu digerakkan oleh para kader terpilih dari wilayah sendiri yang terlatih dan terampil dalam melaksanakan kegiatan rutin di Posyandu. Salah satu kegiatan rutin yang dilakukan kader adalah menggerakkan masyarakat sebelum hari buka Posyandu, dan kunjungan rumah yang dilakukan setelah hari buka Posyandu, jika diperlukan. Materi kader sebagai penggerak masyarakat ini disusun untuk membekali kader agar memahami cara-cara penggerakan masyarakat, bagaimana melakukan komunikasi kepada sasaran sehingga mereka mempunyai pemahaman tentang manfaat Posyandu bagi kesehatan ibu dan anak, dan akhirnya termotivasi untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan Posyandu.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Kader Posyandu untuk melaksanakan penggerakan masyarakat dalam mendukung terlaksananya program imunisasi, diantaranya:

- Mengidentifikasi perilaku dan lingkungan yang masih menjadi masalah dalam keluarga sasaran
- Menetapkan prioritas penyebab masalah yang paling banyak terjadi sehingga dapat menyusun perencanaan kegiatan serta tindak lanjutnya. Identifikasi masalah dapat dilakukan melalui diskusi dengan pendamping teknis di desa/kelurahan.

Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan kader yaitu:

1. Berkoordinasi dengan Bidan Desa/Puskesmas, Aparat Desa/Kelurahan dan UKBM setempat:

- a) Melaporkan hasil pelacakan anak-anak yang belum lengkap status imunisasinya ke bidan desa/petugas kesehatan dan Ketua Posyandu atau ketua lembaga kemasyarakatan (jika kader kesehatan merupakan anggota suatu lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan) untuk membahas apa rencana tindak lanjut kegiatan.
- b) Bersama bidan desa/petugas Kesehatan melakukan koordinasi kepada kepala desa/lurah untuk menyampaikan informasi hasil pelacakan anak-anak yang belum lengkap status imunisasinya untuk ditindaklanjuti bersama. Data Posyandu dapat digunakan sebagai data dasar pembangunan kesehatan di desa/kelurahannya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang Desa).

2. Pendekatan kepada tokoh masyarakat/tokoh agama/tokoh adat

Pendekatan kepada tokoh masyarakat/tokoh agama/tokoh adat dilakukan sejak awal pelaksanaan kegiatan, dan selanjutnya dilibatkan dalam proses kegiatan secara berkesinambungan, dengan tujuan:

- a) Membangun kesamaan pemahaman tentang pentingnya penggerakan masyarakat untuk program imunisasi sebagai upaya meningkatkan status kesehatan keluarga.
- b) Mendukung pelaksanaan program imunisasi agar dapat berjalan dengan baik.
- c) Bersedia menjadi panutan/contoh dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan pentingnya

setiap anak mendapatkan imunisasi.

Langkah persiapan saat melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat/tokoh agama/tokoh adat meliputi:

- a) Melakukan identifikasi keberadaan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat, dll yang ada di wilayah binaan/ wilayah kerja kader.
- b) Melakukan identifikasi potensi, adat istiadat, serta sistem sosial budaya/pengaruh tokoh masyarakat.
- c) Mempersiapkan data/informasi tentang kondisi dan permasalahan kesehatan ibu dan anak khususnya data capaian imunisasi yang ada di daerah binaan Kader Posyandu.
- d) Mempersiapkan pokok-pokok diskusi yang akan disampaikan kepada tokoh masyarakat.
- e) Mengusulkan rencana kegiatan pemberdayaan keluarga dalam pelaksanaan program imunisasi.

Pendekatan pada tokoh masyarakat/tokoh agama/tokoh adat dapat dilaksanakan dengan cara formal ataupun informal, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi sosial budaya di wilayah setempat. Agar komunikasi dengan para tokoh tersebut dapat berjalan dengan efektif, kader harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a) Mencari waktu dan kesempatan yang baik untuk berkomunikasi dengan para tokoh, misalnya: di masjid, di rumah, di sawah, dll
- b) Meyakinkan pentingnya dukungan serta peran para tokoh dalam pelaksanaan program imunisasi.
- c) Membangun komitmen agar para tokoh bersedia bekerja sama.

- d) Membahas rencana kegiatan imunisasi yang akan dilaksanakan bersama para tokoh.

3. Mobilisasi keluarga dan masyarakat dalam program imunisasi

Kader berperan penting menggerakkan keluarga dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program imunisasi. Upaya dalam melibatkan atau menggerakkan keluarga dan masyarakat secara serentak perlu dilakukan untuk mewujudkan keluarga sehat.

Kader harus memiliki keterampilan dalam membangun jejaring dengan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) yang ada di masyarakat seperti: perangkat desa/kelurahan, tenaga kesehatan, tenaga pendidik, dan organisasi kemasyarakatan. Kader diharapkan mampu mengidentifikasi potensi yang dimiliki masyarakat serta mengelolanya dengan baik. Potensi masyarakat merupakan modal utama dalam solusi pemecahan masalah kesehatan yang mandiri.

Mobilisasi keluarga dan masyarakat dalam mendukung program imunisasi dapat dilakukan dengan:

- Mengajak keluarga dan masyarakat untuk membawa bayi dan balita ke Posyandu, Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya.
- Melakukan kunjungan rumah kepada keluarga sasaran yang belum memanfaatkan Posyandu, Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya.
- Mendorong kelompok masyarakat dan lembaga masyarakat potensial yang ada untuk terlibat dalam pelaksanaan kampanye program imunisasi di wilayah binaan secara serentak.

B. Langkah Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengenalan Kondisi wilayah setempat

Pengenalan kondisi wilayah dilakukan dengan mengkaji data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari hasil pencatatan pelaksanaan imunisasi dan Surveilans Kesehatan Berbasis Masyarakat. Data sekunder didapatkan dari data profil desa/kelurahan, profil puskesmas, serta data lainnya seperti *Sustainable Development Goals (SDG)*'s desa.

Hasil pengenalan kondisi wilayah ditindaklanjuti dengan melakukan penentuan prioritas permasalahan kesehatan. Prioritas permasalahan kesehatan dilakukan melalui musyawarah masyarakat desa.

2. Survei Mawas Diri

Survei Mawas Diri (SMD) merupakan suatu upaya bersama yang difasilitasi oleh Puskesmas dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk bersama-sama mengidentifikasi permasalahan kesehatan di masyarakat, dan menggali potensi-potensi yang dimiliki untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Masalah kesehatan disusun menjadi prioritas dengan menggunakan instrumen SMD yang memperhatikan faktor penyebab perilaku dan non perilaku (lingkungan dan kebijakan) terkait masalah kesehatan tersebut.

Tabel 6. Instrumen Survei Mawas Diri

Nomor Rumah:		Nama KK:	
RT/RW:			
Faktor Penyebab/Faktor Risiko		JAWABAN	
		YA	TIDAK
Perilaku:			
• ☐			
• ☐			
• ☐			
Non perilaku/lingkungan:			
• ☐			
• ☐			
• ☐			
Kebijakan			
• ☐			
• ☐			
• ☐			
Potensi Sumber Daya Masyarakat			
• ☐			
• ☐			
• ☐			

3. Musyawarah Masyarakat Desa

Sosialisasi hasil survei mawas diri kepada masyarakat dan perangkat desa melalui musyawarah masyarakat desa/

kelurahan dilakukan untuk menggalang partisipasi warga dalam mendukung program imunisasi.

Waktu	Kegiatan	Pelaksana	Alat dan Bahan	Peran Kader	PJ

4. Perencanaan Partisipatif

Perencanaan kegiatan secara partisipatif disusun setelah sosialisasi yang menghasilkan kesepakatan menyusun rencana usulan kegiatan dalam penyelesaian masalah imunisasi.

Tabel 7. Contoh Perencanaan Partisipatif Posyandu

No.	Jenis Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Pj	Pelaksana yang Terlibat	Kebutuhan Sumber Daya	Jadwal	Tempat	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									

Keterangan pengisian matriks perencanaan:

- 1) Kolom 1: diisi dengan nomor urut
- 2) Kolom 2: diisi dengan jenis kegiatan sesuai dengan zona keberadaan Posyandu
- 3) Kolom 3: diisi dengan tujuan kegiatan
- 4) Kolom 4: diisi dengan sasaran kegiatan
- 5) Kolom 5: diisi dengan penanggung jawab kegiatan
- 6) Kolom 6: diisi dengan pelaksana yang terlibat dalam kegiatan
- 7) Kolom 7: diisi dengan kebutuhan sumber daya (sarana/ fasilitas, dana, dll) setiap jenis kegiatan.
- 8) Kolom 8: diisi dengan jadwal kegiatan
- 9) Kolom 9: diisi dengan tempat kegiatan
- 10) Kolom 10: diisi dengan keterangan, bila ada hal-hal yang perlu dituliskan

Hasil perencanaan partisipatif diarahkan pada kegiatan berskala desa/kelurahan dan sesuai dengan kearifan lokal. Kegiatan perencanaan partisipatif menjadi pedoman untuk menyusun rancangan rencana kerja bagi pemerintah desa/kelurahan dan puskesmas.

5. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan yang telah direncanakan dalam perencanaan partisipatif dilakukan oleh masyarakat melalui Posyandu dan UKBM atau kegiatan lain berupa penggerakan masyarakat dengan dampingan dari teknis terkait. Pencatatan kegiatan dilakukan oleh kader Posyandu dan dilaporkan kepada Pembina Posyandu / Pokja Posyandu Desa sebagai bahan evaluasi.

6. Pembinaan Kelestarian

Pembinaan kelestarian diarahkan untuk menjamin pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dapat berlangsung secara berkesinambungan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pembinaan kelestarian dilaksanakan oleh masyarakat bersama pemerintah desa/kelurahan dan pendamping teknis sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa/kelurahan.

Pembinaan kelestarian dapat dilakukan melalui kegiatan pertemuan berkala, orientasi, sosialisasi, lomba posyandu, penerbitan peraturan lokal dan/atau pemantauan serta evaluasi dari lintas sektoral.

KEMENKES RI

Modul Orientasi Kader Posyandu



**KADER SEBAGAI
PENYULUH MASYARAKAT**

KEMENKES RI

MATERI 5

KADER SEBAGAI PENYULUH

A. Pokok Bahasan 1: Konsep Dasar Komunikasi Antar Pribadi

Penyuluhan kesehatan merupakan penyampaian pesan dari seseorang kepada individu dan/atau kelompok tentang kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat. Penyuluhan kesehatan juga dapat didefinisikan sebagai suatu upaya edukasi/pendidikan melalui penyebarluasan informasi kesehatan sehingga membuat orang menjadi tahu dan mengerti, sadar, serta mau dan mampu melakukan perilaku yang dianjurkan. Kader dapat menjalankan perannya sebagai penyuluh melalui kegiatan pemberian informasi dan edukasi bagi sasaran, khususnya bagi ibu bayi dan ibu baduta. Kader juga dapat memberikan penyuluhan kepada keluarga seperti ayah, ibu, kakek, nenek, pengasuh, dan anggota keluarga lainnya serta kepada masyarakat.

Dalam melakukan penyuluhan, kader harus dapat berkomunikasi secara efektif. Komunikasi merupakan proses penyampaian dan penerimaan pesan, informasi, pendapat, perasaan, atau berita di antara dua orang atau lebih, baik secara verbal (melalui ucapan) dan non-verbal (gerak tubuh, suara, raut wajah, dll).

Komunikasi Antar Pribadi (KAP) merupakan salah satu metode berkomunikasi yang dilakukan secara tatap muka. Komunikasi dalam jaringan (*online*), seperti *video call* tidak dianjurkan dalam KAP karena komunikasi yang berlangsung tidak melibatkan orang seutuhnya (hanya melihat wajah dan mendengarkan suara).

KAP dapat diterapkan oleh kader dalam melaksanakan penyuluhan kepada sasaran serta mengajak dan menggerakkan sasaran untuk mau datang ke Posyandu, melakukan akses pada layanan imunisasi, melakukan pemantauan tumbuh kembang balita, dan perilaku lainnya yang mendukung kesehatan.

Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan KAP, antara lain:

1. Menciptakan suasana menyenangkan dan membangun keakraban;
2. Mengajak seluruh sasaran ikut berbicara dan ikut mendengarkan;
3. Mengajak sasaran agar mengubah perilakunya

1. Ciptakan Suasana Menyenangkan dan Membangun Keakraban

- a. Menciptakan situasi menyenangkan, perasaan santai, rileks, serta tidak merasa tertekan dan takut melalui proses interaksi, belajar bersama, dan mau menerima hal-hal baru, terutama pesan-pesan kesehatan yang disampaikan.
- b. Gunakan cara/teknik, seperti menyebut nama dalam percakapan agar sasaran merasa dihargai dan kehadirannya diakui, melakukan permainan-permainan yang menggembirakan, menggunakan bahasa yang sederhana/bahasa yang dipahami oleh sasaran, melakukan komunikasi non-verbal yang membuat nyaman, sikap menghargai sasaran dengan mendengarkan, dan lain sebagainya.
 - Menambahkan kalimat-kalimat kita dengan nama orang yang diajak bicara, pesan yang kita sampaikan akan terdengar oleh sasaran sebagai pesan yang secara khusus ditujukan kepada orang tersebut. Hal ini akan memberi kesan bahwa kita menyampaikan pesan dengan penuh

perhatian dan kepedulian, sehingga pesan kita akan lebih mengena dan mudah diingat.

Contoh:

- "Menurut Ibu Rika, apa saja ya manfaat dari imunisasi bagi bayi?";
- "Jadi, menurut Ibu Tatik, imunisasi bagi bayi itu penting, ya?"

Agar lebih mudah menghafal nama, gunakanlah sesegera dan sesering mungkin saat kita berkomunikasi dengan sasaran. Menghafalkan nama dapat disiasati dengan menandai ciri-ciri khusus dari sasaran, seperti ciri fisik, logat, kata-kata yang khas diucapkan, gerak-gerik tubuh, dsb. Namun, ciri-ciri tersebut tidak digunakan sebagai julukan saat memanggil. Ciri-ciri tersebut cukup disimpan dalam pikiran untuk membantu kita menghafal/mengingat nama sasaran. Di beberapa daerah tertentu juga terdapat kebiasaan memanggil orang dewasa dengan nama anaknya, misal Ayah Dito untuk memanggil seorang ayah yang anaknya bernama Dito, atau Mama Tasya untuk memanggil seorang ibu yang anaknya bernama Tasya. Secara psikologis, pemanggilan nama anak berpengaruh pada orang dewasa/orang tua. Mereka seolah diingatkan pada peran sebagai orang tua yang bertanggung jawab, penyayang, penyabar dan sifat-sifat baik lainnya. Saat berdiskusi tentang imunisasi, pemanggilan dengan nama anak juga dapat meningkatkan rasa tanggung jawab orang tua.

- Komunikasi non-verbal dapat dilakukan dengan melakukan kontak mata, menggunakan ekspresi wajah dan gerakan tubuh, serta menggunakan suara yang tidak monoton. Ketika berkomunikasi, usahakan untuk melakukan kontak mata dengan menatap di antara dua alis lawan bicara kita, bukan di area kedua mata. Dalam konteks berbicara dalam kelompok/forum, lakukan kontak mata secara merata, tidak hanya pada 1 atau 2 orang saja.
 - Hidupkan suasana dengan memberikan senyuman dan wajah yang ceria. Selain itu, kita juga dapat menggerakkan tangan seperlunya sesuai dengan perasaan yang ingin disampaikan.
- c. Di masa pandemi ini, ada beberapa tantangan komunikasi non-verbal, seperti akses, waktu, dan teknik. Selain itu, dengan kewajiban mengenakan masker, kita juga terbatas dalam berkomunikasi non-verbal, seperti senyuman dan juga volume suara yang memelan atau terdengar datar. Hal tersebut dapat disiasati dengan meningkatkan non-verbal lainnya, seperti memperbesar volume suara, memainkan intonasi suara, memperjelas artikulasi, dan menggunakan gerakan tangan, kepala, atau anggota tubuh lainnya.
- d. Dengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh sasaran. Jangan menyalahkan. Dengarkan dengan menggali hal yang umum agar lebih jelas atau rinci. Dengan didengarkan, sasaran akan merasa dihargai dan lebih terbuka untuk berbicara, sehingga akhirnya mereka juga akan mendengarkan saat kita berbicara dan juga akan lebih termotivasi untuk mengubah perilakunya sendiri.

- e. Berikan apresiasi dengan mengangkat kelebihan atau aspek positif yang disampaikan oleh sasaran. Dengan mengangkat hal positif, sasaran akan semakin merasa nyaman dan termotivasi untuk mendengarkan kader.

2. Semua Ikut Berbicara dan Ikut Mendengarkan

- a. Dalam berkomunikasi, semua pihak harus berbicara dan saling mendengarkan. Bukan hanya kader yang berbicara panjang lebar, tetapi sasaran/masyarakat pun harus ikut berbicara. Jika tidak ikut berbicara, maka sasaran/masyarakat tidak terlibat dalam percakapan dan tidak ikut terlibat dalam mengambil komitmen/kesepakatan.
- b. Dalam memandu diskusi, sebaiknya kader jangan menguasai pembicaraan. Ajak sasaran untuk menyampaikan pengalaman, perasaan, atau pendapatnya. Dengarkan dan simak apa yang disampaikan oleh sasaran dengan pikiran terbuka dan tidak menyalahkan sasaran. Penyampaian pesan juga memerlukan teknik agar sasaran mudah menerima dan menganggap hal yang disampaikan itu penting, tetapi tidak menggurui.

3. Mengarah pada Aksi dan Perubahan Perilaku

Tujuan akhir kegiatan komunikasi bukan hanya sekedar menambah pengetahuan saja. Peningkatan pengetahuan sasaran/masyarakat melalui kegiatan penyuluhan diharapkan dapat mendorong perilaku sasaran, misalnya ibu baduta semula tidak mau membawa anaknya diimunisasi, setelah diberikan penyuluhan dengan metode KAP, akhirnya mau mengakses layanan imunisasi sesuai dengan jenis yang wajib didapatkan.

Untuk mengantarkan sasaran berubah perilakunya, kader dapat:

- Mengelola percakapan yang menawarkan manfaat-manfaat dari perilaku yang diharapkan,
- Menyampaikan risiko yang akan didapat jika tidak menerapkan perilaku kesehatan,
- Menggugah perasaan sasaran,
- Mengumpulkan dukungan kelompok,
- Memperkuat tekad sasaran,
- Dan membantu sasaran membuat komitmen/kesepakatan sehingga sasaran mau benar-benar melakukan tindak lanjut yang mengarah pada perubahan perilaku.

KAP dapat dilaksanakan dengan menggunakan media KIE atau alat bantu untuk menyampaikan informasi serta memperlancar komunikasi dan penyebaran informasi. Beberapa media KIE yang sering dipakai sebagai alat bantu komunikasi, antara lain brosur, lembar balik, *booklet*, buku KIA, buku saku, dan media lainnya.

B. Pokok Bahasan 2: Komunikasi Antar Pribadi (KAP) pada Pelaksanaan Posyandu dalam Masa Pandemi COVID-19

KAP dapat dilakukan sebelum, saat, dan sesudah hari buka Posyandu.

- Sebelum hari buka Posyandu
Kader mengingatkan atau mengajak sasaran untuk datang saat hari buka Posyandu.
- Saat hari buka Posyandu
Kader melakukan penyuluhan/edukasi terkait hasil pemantauan

pertumbuhan dan perkembangan, imunisasi, tanda bahaya kehamilan, tanda bahaya baduta sakit, dan lain sebagainya.

Kader juga mengingatkan pengunjung Posyandu untuk menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19, seperti segera pulang ke rumah, segera mandi dan mengganti pakaian, menerapkan etika batuk, menjaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan tidak keluar rumah kecuali keadaan mendesak.

- Sesudah hari buka Posyandu

Kader dapat mendampingi kelas ibu hamil atau kelas balita dan melakukan kunjungan rumah pada sasaran yang tidak hadir ke Posyandu untuk menanyakan perihal ketidakhadirannya dan hasilnya dicatat dalam buku laporan kader.

Pada masa pandemi COVID-19, kegiatan komunikasi dapat dilakukan menggunakan gawai (HP, laptop, dll). Platform komunikasi yang dapat digunakan melalui gawai, antara lain telepon, SMS, *WhatsApp*, *Facebook*, *Instagram*, *TikTok*, dsb. Pemilihan platform komunikasi dapat disesuaikan dengan platform yang paling banyak digunakan oleh kelompok sasaran. Namun harap diingat, bahwa walaupun tidak dianjurkan karena hasilnya kurang maksimal, KAP secara *online/daring* tetap dapat dilakukan pada masa pandemi dengan syarat bukan komunikasi yang satu arah.

Merangkai pesan melalui daring perlu memperhatikan beberapa hal berikut.

- Buatlah pesan yang singkat, jelas, dan mudah dipahami.
- Upayakan pesan yang dibuat berisi satu pesan pokok.
- Pastikan pesan/informasi yang disampaikan berasal dari sumber yang akurat dan dapat dipercaya (bukan *hoaks*)

- Sebelum mengirimkan pesan, teliti kembali apakah terdapat kesalahan penulisan dan periksa kembali ketepatan isi pesan
- Perhatikan juga waktu-waktu yang tepat untuk mengirimkan pesan yang memungkinkan sasaran dapat membaca pesan tersebut dengan baik

KEMENKES RI

LAMPIRAN 1

Panduan Praktik Berkenalan dan Menghafal Nama

1. Fasilitator membagi peserta ke dalam 5 kelompok
2. Tiap kelompok diminta untuk membuat lingkaran
3. Fasilitator mencontohkan permainan menghafal nama "Terima kasih, nama saya..".

Dia mulai menyebut namanya sendiri: "Saya Ani".

Lalu minta peserta di sebelah kanan, mengucapkan "Terima kasih, Bu Ani. Nama saya Ratna.";

Minta sebelah kanannya Ibu Ratna mengucapkan "Terima kasih Bu Ani, Bu Ratna, nama saya Nisa.";

Demikian seterusnya sampai 7 atau 8 orang;

4. Fasilitator meminta tiap kelompok secara bersamaan mempraktikkan permainan menghafal nama selama +/- 5 menit
5. Selanjutnya, fasilitator meminta perwakilan salah satu kelompok untuk menyebutkan nama seluruh anggota kelompoknya
6. Fasilitator menyimpulkan bahwa dengan langsung/segera menggunakan nama dan menyebutkan secara berulang dapat membantu menghafal nama

LAMPIRAN 2

Panduan Praktik Bertanya dan Mendengarkan

1. Fasilitator meminta seluruh peserta untuk duduk berpasangan dan berhadapan
2. Salah satu orang dalam pasangan berperan sebagai kader yang akan bertanya dan mendengarkan masyarakat sasaran, sedangkan satu orang yang lain berperan sebagai masyarakat sasaran yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kader.
3. Secara bersamaan, setiap pasangan diberi waktu +/- 5 menit untuk melakukan praktik
4. Setelah seluruh peserta selesai praktik dalam pasangan, fasilitator meminta salah satu peserta menceritakan pengalamannya ketika menjadi kader (seperti: apa yang dirasakan ketika bertanya kepada sasaran, poin/hal penting apa saja yang ditangkap dari jawaban yang disampaikan oleh sasaran, dsb), serta satu peserta lainnya yang berperan sebagai masyarakat sasaran (seperti: apa yang dirasakan ketika ditanya/diminta bercerita, apakah kader memperhatikan ketika sasaran berbicara, dsb)
5. Berdasarkan pengalaman yang disampaikan oleh perwakilan peserta, fasilitator memberikan simpulan dan pembulatan tentang 'bertanya dan mendengarkan'

LAMPIRAN 3

Panduan Penggunaan Alat Bantu Sasaran Ibu Baduta

Pengantar

Orang tua atau pengasuh pasti sangat menyayangi anaknya (atau anak yang diasuhnya) dan menginginkan anaknya tumbuh menjadi anak yang sehat. Salah satu upaya agar anak menjadi sehat adalah dengan imunisasi.

Tujuan

Agar ibu baduta memandang penting imunisasi sesuatu yang wajib diberikan kepada anaknya.

Jumlah peserta

1 – 15 orang

Target peserta

Ibu bayi dan baduta serta suami

Alat dan Bahan

Gambar Cita-cita

Gambar Program Imunisasi

Waktu

10-15 menit

Langkah

1. Perkenalan (kader dan ibu bayi dan baduta) fasilitator menyebut nama seorang ibu bayi dan baduta berkali-kali
2. Sampaikan tujuan yaitu mengajak ibu-ibu untuk belajar

tentang perilaku sehat yaitu pentingnya membawa bayi dan baduta mendapatkan imunisasi sesuai usia.

3. Lakukan bina suasana dengan permainan atau lagu sederhana.
4. Tanyakan makanan kesukaan ibu-ibu? Dengarkan secara aktif
5. Tanyakan, apa harapan ibu pada bayi dan badutanya saat ini? berharap jadi apa anaknya nanti ? dengarkan secara aktif. Gali tujuan atau yang ingin dipetik dari harapan itu (tekanan tujuan pribadi/keluarga, maupun masyarakat). Apabila mendapat jawaban normatif (berguna bagi masyarakat, tergantung anak dll), gali atau dengarkan secara aktif.
6. Tunjukkan gambar-gambar, bila tersedia, cocokkan dengan harapan yang disampaikan.
7. Gunakan bahasa *theatre of mind*.

Contoh:

Tentara : Bangga kan anaknya jadi tentara. Saat anak pulang ke rumah lebaran atau hari besar, pakai seragam lengkap, gagah, orang-orang di kampung membicarakan, eh itu anaknya bu/ pak SEBUT NAMA-NAMA PESERTA UNTUK RELEVANSI? Wah, gagah benar. Banggakah ibu/ bapak? Mau anaknya begitu?

Anak-anak di kampung jadi terinspirasi. Oh, aku juga bisa jadi tentara kaya anaknya bu/ pak SEBUT NAMA-NAMA PESERTA UNTUK RELEVANSI. Mereka jadi semangat belajar, makannya juga yang bergizi, sering olah raga agar seperti anaknya SEBUT NAMA-NAMA PESERTA UNTUK RELEVANSI? Wah, jadi inspirasi warga kampung? Mau anaknya begitu?

8. Provokasi dengan mempertanyakan dan contoh kebalikan.

Contoh:

Bu/ Pak SEBUT NAMA serius anaknya mau SEBUT CITA-CITA? atau omong doang? Tidak peduli anaknya kelak mau jadi apa? Preman kek, penganggur kek? Bagaimana

9. Tanyakan, apa yang bisa ibu perbuat saat ini agar anaknya kelak menjadi seperti yang diimpikan? Dengarkan. Gali. Biasanya, salah satu jawabannya adalah makanan.

Cita-cita

1. Pertanyaan utama: *Bu/Pak, kalau boleh tahu, apa sih mimpi atau harapan pada anak ibu/ bapak nanti kalau sudah besar? Harapannya, anak nanti kalau besar jadi apa?*

Bila mendapat jawaban normatif (berguna bagi masyarakat, tergantung anak dll), gali atau dengarkan secara aktif.

2. Buat kelompok berisi 4-6 orang dengan permainan jongkok-berdiri senang. Bagikan masing-masing kelompok 1 set gambar cita-cita. Sampaikan: *silahkan dilihat-lihat, apa ada yang mirip dengan harapan atau cita-cita kita? Silahkan diobrolkan nanti kita bahas bersama.*
3. Pilih jubir kelompok dengan demokrasi telunjuk. Ajak jubir bercerita.
4. Kuatkan harapan dengan membahas per cita-cita. Gali atau ulas manfaat pribadi dan manfaat sosial dan sedikit provokasi.
- a. Gunakan bahasa *theatre of mind*. Contoh:

Tentara: Bangga kan anaknya jadi tentara. Saat anak pulang ke rumah lebaran atau hari besar, pakai seragam lengkap, gagah, orang-orang di kampung membicarakan, eh itu anaknya Bu/ Pak SEBUT NAMA-NAMA PESERTA UNTUK RELEVANSI? Wah, gagah benar. Banggakah ibu/ bapak? Mau anaknya begitu?

Anak-anak di kampung jadi terinspirasi. Oh, aku juga bisa jadi tentara kaya anaknya Bu/Pak SEBUT NAMA-NAMA PESERTA UNTUK RELEVANSI. Mereka

jadi semangat belajar, makannya juga yang bergizi, sering olah raga, kecilnya diimunisasi lengkap agar seperti anaknya. SEBUT NAMA-NAMA PESERTA UNTUK RELEVANSI? Wah, jadi inspirasi warga kampung? Mau anaknya begitu?

- b. Provokasi dengan mempertanyakan dan contoh kebalikan.
Contoh:

Bu/Pak SEBUT NAMA serius anaknya mau SEBUT CITA-CITA? atau omong doang? Tidak peduli anaknya kelak mau jadi apa? Preman kek, penganggur kek? Bagaimana?

5. Sampaikan pertanyaan tur besar: *kalau memang serius anaknya mau jadi SEBUT CITA-CITA DAN NAMA-NAMA, pertanyaannya supaya anak ibu/ bapak bisa jadi seperti yang ibu/ bapak impikan, apa yang mesti diperhatikan? Rangkum.*
6. Sampaikan tur mini pada imunisasi. Mengapa anak harus diimunisasi? *Untuk apa anak diimunisasi ?* Umumnya menyebut supaya sehat, tidak mudah sakit, tapi tidak mengetahui secara mendalam mengapa harus diimunisasi lengkap dan rutin (jawaban yang umum: supaya sehat, tidak mudah sakit, dan lainnya).

Kaitkan dengan cita-cita. *Tadi ibu/ bapak SEBUT NAMA-NAMA ingin anaknya jadi SEBUT CITA-CITA. Itu serius? Apa bisa terwujud kalau anaknya sakit-sakitan? Jadi imunisasi apa saja yang harus didapatkan badutanya?*

7. Provokasi. Kalau ada anggota keluarga lain menolak imunisasi, bagaimana? Apa yang kita lakukan? **BAHAS TENTANG PENYAKIT YANG BISA DICEGAH DENGAN IMUNISASI**

8. *Kalau ibu/bapak SEBUT NAMA-NAMA serius ingin anaknya jadi SEBUT CITA-CITA dan sudah tahu kalau harus diimunisasi, kapan mulai anaknya harus diimunisasi? Serius?*
9. Tanyakan apakah ibu saat ini telah membawa bayi dan badutanya rutin diimunisasi? Jelaskan tentang manfaat imunisasi sesuai usia bayi dan baduta sampai selesai sesuai dengan jenis imunisasi.
10. *Gambar baduta yang sedang diimunisasi, ini gambar apa? Apakah ibu membawa bayi dan badutanya mendapatkan imunisasi? Apakah ibu mengikuti arahan Kader Posyandu melakukan imunisasi? Ibu-ibu ini adalah jenis imunisasi sesuai usia bayi dan baduta (tunjukkan Tabel Imunisasi sesuai usianya/dibuat semenarik mungkin sehingga ibu-ibu tertarik melihatnya. Jelaskan manfaat setiap jenis imunisasi dan hubungannya dengan usia balita.*
11. Kembalikan ke gambar harapan. Sampaikan, betulkah ibu ingin anaknya nanti seperti ini? provokasi apakah serius? Betulan atau hanya omong-omong saja? Atau tidak peduli anaknya jadi apa nanti?

Karena ibu betul-betul ingin anaknya menjadi (tunjukkan gambar), maka ibu harus membawa anaknya diimunisasi rutin dan sampai lengkap sesuai anjuran. Ada 10 jenis imunisasi yang harus diberikan bagi bayi dan baduta agar dapat terhindar dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).

12. Tunjukkan gambar. Tanyakan: Bagaimana cara kerja imunisasi di dalam tubuh bayi dan baduta? Benarkah imunisasi ini bisa mencegah penyakit menular? Mengapa harus diimunisasi? Setelah ibu-ibu menjawab, apresiasi lalu tambahkan informasi:

Saat ini bayi dan baduta ibu sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan sehingga perlu daya tahan tubuh yang maksimal

jika terjadi suatu penyakit menular yang bisa saja menyerang kapan pun apalagi jika kondisi lingkungan kita kurang baik dan kurang memadai, sehingga tubuh bayi dan baduta perlu mempertahankan tubuhnya bertahan dari serangan penyakit tersebut. Imunisasi adalah proses untuk membuat seseorang kebal atau imun terhadap suatu penyakit. Proses ini dilakukan dengan membuat pemberian vaksin yang merangsang sistem kekebalan tubuh agar kebal terhadap penyakit tertentu. Lengkapnya jenis imunisasi sesuai usia akan membentuk kekebalan dan membuat bayi dan baduta ibu lebih kuat dan sehat tentunya. Manfaat imunisasi pada anak:

- Melindungi anak dari beberapa jenis penyakit infeksi dengan cara yang paling sederhana dan murah
- Membantu anak untuk tumbuh kembang secara optimal
- Secara ekonomis, anak yang sehat akan membantu menghindari pengeluaran yang tidak perlu saat anak sakit.
- Tanyakan komitmen dari peserta: Jadi agar harapan ibu terwujud, yaitu supaya jadi (gambar), ibu mau membawa bayi dan badutanya diimunisasi sesuai usia
- Tutup dengan doa dan ucapan terima kasih.

Gambar Cita-cita: Bisa ditambahkan gambar lain yang dirasa perlu





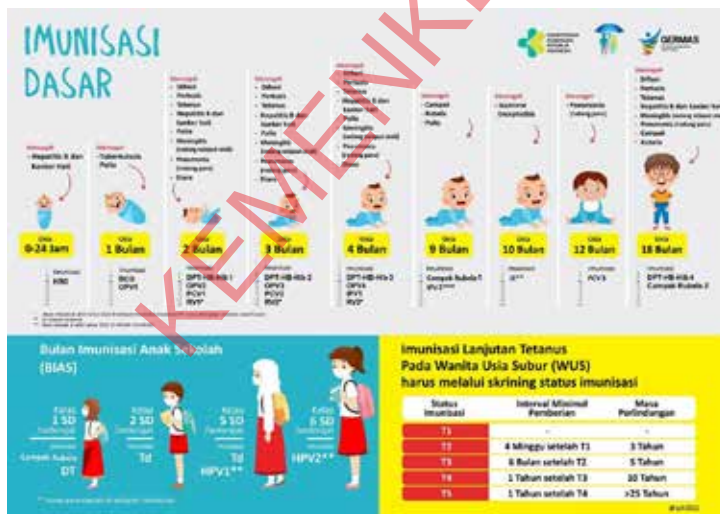








Gambar Media KIE



LAMPIRAN 4

Panduan Penggunaan Alat Bantu KAP: Poster Pertanyaan Pihak Ketiga

Pengantar

Kebanyakan ibu/pengasuh sehari-hari sibuk bekerja, apakah itu pekerjaan rumah tangga atau pun pekerjaan kantor. Oleh karena itu kadang terlupa jadwal imunisasi yang tepat. Kegiatan ini dapat dilaksanakan di **Posyandu (langkah ke-5)** atau **Kunjungan Rumah** (sub sesi).

Tujuan

Membantu untuk mengingat sekaligus memotivasi ibu/pengasuh mengenai jadwal imunisasi.

Jumlah Peserta

Satu orang

Target peserta

Ibu hamil/ibu menyusui/pengasuh/anggota keluarga

Peralatan

Poster Imunisasi

Waktu

3-4 menit

Langkah

1. Ibu/Bapak, ini ada poster. Belum dicetak, belum dipasang. Masih rencana. Nah, sebelum dicetak boleh saya minta bantuan ibu/bapak menilai poster ini? SETELAH ITU, TUNJUKKAN POSTER

2. Menurut ibu/ bapak gambarnya jelaskah? Gambar apa yang ibu/ bapak lihat? Apa lagi? Kalau ini apa? USAHAKAN AGAR IBU/ BAPAK MENGLARIFIKASI GAMBAR VAKSIN, GAMBAR FASYANKES, GAMBAR BAYI/ANAK, GAMBAR TENAGA KESEHATAN
3. Kira-kira, sulitkah memahami pesan poster ini? Apa sih pesan yang ingin disampaikan? Apa lagi? USAHAKAN AGAR SASARAN MENGLARIFIKASI ASPEK BERIKUT: JADWAL IMUNISASI, JENIS IMUNISASI, TEMPAT IMUNISASI. BILA KESULITAN, ARAHKAN SASARAN DENGAN MENGAJUKAN PERTANYAAN SEPERTI: Berapa usia anak diimunisasi...? Kalau untuk mencegah anak sakit...? Waktu-waktu imunisasi....? Di mana tempat imunisasi...?
4. Kalau buat warga di kampung, kira-kira apakah ada informasi baru dalam poster ini? Apakah itu?
5. Kalau mereka melihat poster ini, apakah pesan ini akan dianggap penting? Apanya yang penting?
6. Menurut ibu/bapak sendiri, bagaimana? Apakah pesan ini penting?
7. Kalau warga kampung melihat poster ini, apakah mereka mau mengikutinya?
8. Kalau ibu/bapak sendiri, apakah mau mengikutinya? Kapan saja?
9. PROVOKASI. Ibu/bapak betulan ini? Serius? Nanti kalau sehabis pulang dari Posyandu/Fasyankes lupa bagaimana? Apa benar sudah dicatat? KALAU MENGATAKAN SUDAH MELAKUKAN, KUATKAN.
10. Kalau begitu, kita ijab/akad yuk. KALAU PUN MENGATAKAN SUDAH MELAKUKAN, TETAP AJAK AKAD. Ayo kita salaman dan ibu/bapak ikuti kata-kata saya ya.

Saya (SEBUT NAMA) berjanji

Akan selalu mengingat jadwal imunisasi demi kesehatan anak di 13 waktu penting:

- saat anak usia kurang dari 24 jam
- saat anak usia 1 bulan
- saat anak usia 2 bulan
- saat anak usia 3 bulan
- saat anak usia 4 bulan
- saat anak usia 9 bulan
- saat anak usia 10 bulan
- saat anak usia 12 bulan
- saat anak usia 18 bulan
- saat anak usia kelas 1 SD/Madrasah/ sederajat
- saat anak usia kelas 2 SD/Madrasah/ sederajat
- saat anak usia kelas 5 SD/Madrasah/ sederajat
- saat anak usia kelas 6 SD/Madrasah/ sederajat
- INGATKAN. Langsung dicatat. Tidak menunggu besok.

11. Tutup dengan doa dan ucapan terima kasih.

Lampiran Kasus

1. Kelompok 1

Ibu Manda memiliki bayi berusia 2 bulan. Dengan mengacu pada buku KIA, silakan siapkan pesan-pesan apa saja yang perlu disampaikan oleh kader kepada Ibu Manda dalam rangka menjaga kesehatan bayinya.

2. Kelompok 2

Minggu depan, bayi Ardi dijadwalkan untuk mendapatkan imunisasi. Dengan mengacu pada buku KIA, silakan siapkan pesan-pesan pengingat sekaligus memotivasi Ibu Ardi agar membawa bayi Ardi untuk diimunisasi.

3. Kelompok 3

Ibu Arini telah selesai mendapatkan layanan pada hari buka Posyandu. Sebelum pulang, Ibu Susi sebagai kader bertugas mengingatkan Ibu Arini tentang hal-hal apa saja yang perlu dilakukan sepulang dari Posyandu. Perwakilan anggota kelompok diminta untuk berperan sebagai Ibu Kader Susi yang mempraktikkan KAP dalam memberikan edukasi kepada Ibu Arini

4. Kelompok 4

Setelah hari buka Posyandu, Ibu Rani sebagai kader bertugas melakukan kunjungan ke rumah Ibu Sandra untuk memantau kepatuhan minum tablet tambah darah (TTD) dan memotivasi Ibu Sandra untuk rutin meminum TTD. Perwakilan anggota kelompok diminta untuk berperan sebagai Ibu Kader Rani yang mempraktikkan KAP dalam melakukan kunjungan ke rumah Ibu Sandra yang sedang hamil.

C. Pokok Bahasan 3: Janji Temu

Membuat janji temu masa pandemi COVID-19

Persiapan sebelum hari Posyandu

- Petugas kesehatan membuat pengumuman pemberitahuan mengenai jadwal imunisasi selama masa pandemi COVID-19, dengan menyertakan nomor telepon/WA/SMS untuk membuat janji temu (daftar) imunisasi yang akan datang;
- Membuat jadwal janji temu imunisasi yang akan datang dengan orang tua atau pengantar agar kedatangan sasaran imunisasi dapat diatur dan berjalan dengan baik (melalui telepon, SMS, WA, dan lain-lain);
- Memastikan kader, anak dan pengantar dalam kondisi sehat untuk datang ke tempat pelayanan imunisasi, misalnya dengan menanyakan riwayat demam, alergi, riwayat bepergian ke daerah lain/ riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi COVID-19.
- Mengingatkan orang tua atau pengantar untuk membawa anak ke posyandu sesuai hari dan jam yang telah ditentukan dengan membawa buku KIA atau buku catatan imunisasi
- Membatasi jumlah pengantar hanya 1 orang saja

Ketentuan Waktu Pelayanan Imunisasi di Puskesmas Keliling

- Tentukan jadwal hari atau jam pelayanan puskesmas keliling;
- Hubungi beberapa orang tua yang rumahnya berdekatan dengan lokasi imunisasi untuk memberi tahu tentang hari dan jam puskesmas keliling;
- Dalam satu kali sesi puskesmas keliling, waktu layanan tidak

lama dan batasi jumlah sasaran yang dilayani dalam satu kali sesi pelayanan (maksimal 5 - 6 anak). Jika jumlah sasaran banyak, maka pelayanan imunisasi puskesmas keliling dibagi menjadi beberapa sesi untuk meminimalkan risiko penyebaran infeksi;

- Koordinasi dengan lintas program lainnya untuk memberikan pelayanan kesehatan lain bersamaan dengan imunisasi jika memungkinkan;
- Informasikan nomor telepon petugas kesehatan atau kader yang dapat dihubungi oleh orang tua atau pengantar untuk membuat jadwal pelayanan imunisasi.

Di Hari Buka pelayanan di Posyandu, kader posyandu wajib:

- Dalam keadaan sehat untuk memberikan pelayanan (tidak demam, batuk, pilek, dan lain-lain);
- Menggunakan masker bedah/masker medis/masker kain 3 lapis saat pelayanan;
- Memastikan ruang/tempat pelayanan imunisasi bersih;
- Memastikan tersedianya fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* di posyandu;
- Memastikan tempat duduk antar petugas dan kader serta orang tua sesuai prinsip menjaga jarak aman 1 – 2 meter;
- Pada saat pelayanan imunisasi: a. Mencuci tangan dengan sabun dan air atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum dan setelah membantu pelayanan imunisasi. b. Mencatat hasil pelayanan imunisasi pada buku catatan/register imunisasi atau buku KIA. c. Mengingatkan orang tua tentang jadwal imunisasi berikutnya

- Membersihkan area posyandu sesudah selesai pelayanan dengan cairan disinfektan.

Tempat pelayanan imunisasi sebaiknya memiliki kriteria – kriteria di bawah ini:

- Ruang/tempat pelayanan imunisasi yang cukup besar dengan sirkulasi udara yang baik atau dapat juga dilakukan di teras rumah ataupun mobil puskesmas keliling di depan rumah salah satu sasaran imunisasi atau balai desa, tempat ibadah dan lain- lain;
- Bila menggunakan kipas angin, letakkan kipas angin di belakang petugas kesehatan agar arah aliran udara kipas angin mengalir dari tenaga kesehatan ke sasaran imunisasi. Pastikan tidak ada anggota keluarga dalam rumah tersebut yang sakit;
- Jika dilakukan di rumah, ruang/tempat pelayanan imunisasi terpisah dari ruangan untuk anggota keluarga lainnya;
- Ruang/tempat pelayanan bersih dengan membersihkan sebelum dan sesudah pelayanan dengan cairan disinfektan;
- Fasilitas mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir (sebaiknya letaknya di luar rumah) atau *hand sanitizer*;
- Meja untuk pelayanan imunisasi yang terpisah dengan petugas lainnya agar jarak aman 1 – 2 meter;
- Sediakan tempat duduk bagi orang tua atau pengantar untuk menunggu sebelum dan 30 menit sesudah imunisasi dengan jarak aman antar tempat duduk 1 – 2 meter. Atur agar tempat/ ruang tunggu sasaran yang sudah dan sebelum imunisasi terpisah. Jika memungkinkan tempat untuk menunggu 30 menit sesudah imunisasi di tempat terbuka.

Lembar Kasus

Kasus 1:

Meylina Puspitasari adalah anak Bapak Sakri Sabatmaja yang saat ini berusia 9 bulan. Dengan mengacu pada buku KIA, susunlah pesan singkat kepada Bapak Sakri Sabatmaja untuk melakukan janji temu dengan petugas Puskesmas untuk melakukan imunisasi Meylina Puspitasari

Kasus 2:

Woro Sandra Aryani adalah anak Bapak Bambang Purwanto yang pada saat Posyandu ditemukan bahwa status imunisasinya tidak lengkap. Dengan mengacu pada buku KIA, susunlah pesan singkat kepada Bapak Bambang Purwanto untuk melakukan janji temu dengan petugas Puskesmas untuk melakukan konseling akan pentingnya imunisasi.

KEMENKES RI

KEMENKES RI

Modul Orientasi Kader Posyandu



**LANGKAH PEMBELAJARAN
(UNTUK FASILITATOR)**

KEMENKES RI

MATERI 2

PENGENALAN PROGRAM IMUNISASI SERTA PENYAKIT-PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I)

I. DESKRIPSI SINGKAT

Memahami Program Imunisasi merupakan suatu hal yang penting bagi kader Posyandu karena Imunisasi merupakan layanan wajib yang dapat diberikan di Posyandu walaupun dalam pemberiannya yang melaksanakan adalah petugas kesehatan. Namun dalam menggerakkan masyarakat yang merupakan sasaran program Imunisasi agar dapat mengakses layanan Imunisasi maka peran kader Posyandu sangat berguna untuk menginformasikan dan mencatat data sasaran serta kegiatan pelayanan imunisasi di Posyandu. Sehubungan dengan itu, kader Posyandu harus mampu dan sebaiknya terampil melaksanakan peran dan fungsinya dalam menginformasikan (penyuluhan) mengenai tujuan dan manfaat program Imunisasi terutama mengenalkan PD3I pada saat pelayanan Imunisasi di Posyandu maupun di luar hari buka Posyandu. Kemampuan kader Posyandu merupakan kunci keberhasilan dalam menggerakkan sasaran akses pada pelayanan imunisasi di Posyandu maupun fasilitas pelayanan Kesehatan lainnya.

Pada materi inti 2 ini, ruang lingkup yang akan dibahas meliputi Imunisasi, Jadwal Pemberian Imunisasi Rutin dan PD3I (Penyakit-penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi).

II. TUJUAN PEMBELAJARAN

A. Tujuan Pembelajaran Umum

Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu melakukan peran

dan fungsinya dalam mengenalkan program Imunisasi dan PD3I.

B. Tujuan Pembelajaran Khusus

Setelah selesai mengikuti kegiatan ini, peserta orientasi mampu:

1. Menjelaskan program Imunisasi dan PD3I.
2. Melakukan penyebaran informasi tentang program imunisasi dan PD3I.

III. POKOK BAHASAN

Dalam modul ini akan dibahas pokok bahasan-pokok bahasan sebagai berikut, yaitu:

- A. Imunisasi
- B. Jadwal Pemberian Imunisasi Rutin
- C. Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)

IV. MEDIA DAN ALAT BANTU

- Bahan tayang
- Modul orientasi
- Laptop/komputer
- LCD proyektor
- ATK
- *Flipchart*
- Spidol
- *Puzzle* (12 jenis PD3I)
- Media imunisasi
- Video/film jika ada

V. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Jumlah jam yang digunakan dalam penyampaian materi ini sebanyak 3 JPL (Teori= 1 JPL, Penugasan= 2 JPL, Praktik Lapangan=0, @45 menit). Dalam memudahkan proses pembelajaran, dilakukan langkah-langkah kegiatan pembelajaran sebagai berikut.

A. Langkah 1 Pengkondisian (5 menit) Langkah pembelajaran:

1. Fasilitator menyapa peserta dengan ramah dan hangat. Apabila belum pernah menyampaikan sesi di kelas, mulailah dengan perkenalan. Perkenalkan diri dengan menyebutkan nama lengkap, instansi tempat bekerja dan judul materi yang akan disampaikan.
2. Menciptakan suasana nyaman dan mendorong kesiapan peserta untuk menerima materi dengan menyepakati proses pembelajaran.
3. Dilanjutkan dengan penyampaian judul materi, deskripsi singkat, tujuan pembelajaran serta ruang lingkup pokok bahasan yang akan dibahas pada sesi ini.

B. Langkah 2

Penyampaian pokok bahasan menggunakan bahan tayang/ajar/*ppt* tentang imunisasi, Jadwal Pemberian Imunisasi Rutin dan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) selama 35 menit.

Langkah Pembelajaran:

1. Fasilitator melakukan curah pendapat dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta untuk mengukur pemahaman peserta tentang Program Imunisasi dan PD3I.

2. Fasilitator mencatat semua pendapat peserta di kertas *flipchart*. Selanjutnya merangkum dan menyampaikan paparan materi mengenai program imunisasi sesuai urutan pokok bahasan dengan menggunakan bahan tayang.
3. Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya atau menyampaikan klarifikasi, selanjutnya fasilitator menyampaikan jawaban atau tanggapan yang sesuai.

C. Langkah 3

Penyampaian dan pembahasan mengenai pelaksanaan pengenalan program Imunisasi, Jadwal Pemberian Imunisasi Rutin, dan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) bagi sasaran selama 60 menit

Langkah pembelajaran:

1. Fasilitator membagi peserta dalam 3 kelompok, tiap kelompok diberikan Lembar Jadwal dan Penapisan Imunisasi yang harus diisi oleh tiap kelompok peserta secara cepat dan tepat. Penugasan yang diberikan kepada kelompok dengan mencabut kertas yang sudah disiapkan dalam sebuah wadah dan tiap ketua kelompok mengambil kertas penugasan.
 - a. Kelompok 1 bertugas mengisi Jadwal Pemberian Imunisasi Dasar bagi Bayi dan Lanjutan bagi Baduta
 - b. Kelompok 2 bertugas mengisi Jadwal Pemberian Imunisasi pada Anak Usia Sekolah Dasar/Madrasah/Sederajat
 - c. Kelompok 3 bertugas mengisi Penapisan Status Imunisasi Tetanus dan Pemberian Imunisasi Lanjutan Td Pada WUS

Isian lembar tugas telah disiapkan fasilitator berupa kertas metaplan yang telah bertuliskan jawaban dari masing-masing jadwal dan penapisan.

2. Fasilitator memberikan kesempatan kepada perwakilan kelompok untuk mengambil kertas-kertas jawaban yang sesuai menurut mereka untuk ditempelkan ke lembar tugas masing-masing. Berikan waktu 20 menit kepada peserta untuk mengisi lembar tugas, setelah waktu habis maka seluruh peserta harus mengangkat tangan, selesai/tidak selesai mengisi jawaban.
3. Fasilitator beserta peserta melihat hasil dari penugasan, bahas bersama dan menjelaskan jawaban yang benar dan nilai tugas kelompok sehingga menghasilkan kelompok yang paling banyak menjawab benar maka itu adalah kelompok yang menang berikan apresiasi. Dilakukan selama 15 menit.
4. Fasilitator memberikan kesempatan kembali kepada peserta dalam kelompoknya (3 kelompok) untuk bermain *Puzzle* PD3I. Siapkan potongan-potongan kertas berisikan gambar dan tulisan terkait PD3I. Ada 12 jenis PD3I yang dibagi dalam 3 penugasan kelompok, tiap kelompok menyusun 4 jenis penyakit. Beri kesempatan kepada peserta untuk menyusun *puzzle* selama 15 menit, jika waktu habis maka peserta harus berhenti menyusun.
5. Fasilitator meminta setiap kelompok menyampaikan hasil menyusun *puzzle* PD3I. Selanjutnya bahas dengan peserta jawaban yang benar dan beri kesempatan untuk bertanya atau menyampaikan klarifikasi. Kemudian fasilitator menyampaikan jawaban atau tanggapan yang sesuai serta tentukan pemenang penyusunan *Puzzle* PD3I yang menyusun paling banyak yang benar, berikan apresiasi. Dilakukan selama 40 menit.

D. Langkah 4

Penyampaian rangkuman tentang keseluruhan materi (5 menit).

Langkah pembelajaran:

1. Fasilitator mengajak peserta untuk mengungkapkan kembali beberapa hal penting tentang Imunisasi, Jadwal Pemberian Imunisasi Rutin dan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) pada sesi ini, mengacu pada tujuan pembelajaran.
2. Fasilitator menutup proses pembelajaran pada sesi ini, dengan mengucapkan terima kasih serta memberikan apresiasi kepada semua peserta yang telah berpartisipasi aktif sehingga tujuan pembelajaran pada sesi ini dapat tercapai.

VI. URAIAN MATERI 2

Terlampir.

VII. REFERENSI

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi.

MATERI 3

KADER SEBAGAI PENCATAT SEDERHANA

I. DESKRIPSI SINGKAT

Pencatatan dan pelaporan dalam penyelenggaraan program imunisasi sangat penting dilakukan di semua tingkat administrasi guna mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan maupun evaluasi.

Kader memiliki salah satu tugas yaitu sebagai pencatat sederhana. Pencatatan sederhana meliputi pencatatan / register sesuai Sistem Informasi Posyandu (SIP) dan dilakukan dengan mengacu pada formulir standar yang ditetapkan.

Pada materi 3 ini, ruang lingkup terkait materi Kader sebagai Pencatat Sederhana yang akan dibahas meliputi peran kader dalam melakukan Pendataan Riil Sasaran Program Imunisasi, Pencatatan Hasil Layanan Imunisasi di Posyandu, Pelacakan dan Kunjungan ke Ketua Kelompok Dasa Wisma untuk Menjangkau Bayi dan Baduta yang Belum/Tidak Lengkap Status Imunisasinya, serta Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Berbasis Masyarakat.

II. TUJUAN PEMBELAJARAN

A. Tujuan Pembelajaran Umum

Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu melaksanakan kegiatan pencatatan sederhana dengan mengacu pada formulir standar.

B. Tujuan Pembelajaran Khusus

Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu:

1. Memahami dan mampu melaksanakan pendataan riil sasaran program imunisasi
2. Memahami dan mampu melaksanakan pencatatan hasil layanan imunisasi
3. Memahami dan mampu melaksanakan kegiatan pelacakan bayi dan baduta yang belum/tidak lengkap status imunisasinya
4. Memahami dan mampu melaksanakan surveilans kesehatan berbasis masyarakat

III. POKOK BAHASAN

Dalam modul ini akan dibahas pokok bahasan-pokok bahasan sebagai berikut, yaitu:

- A. Manfaat Pencatatan dalam Pelaksanaan Program Imunisasi dan Peran Kader Sebagai Pencatat Sederhana,
- B. Pendataan Riil Sasaran Program Imunisasi,
- C. Pencatatan Hasil Layanan Imunisasi di Posyandu,
- D. Pelacakan dan Kunjungan ke Ketua Kelompok Dasa Wisma untuk Menjangkau Bayi dan Baduta yang Belum/Tidak Lengkap Status Imunisasinya, dan
- E. Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Berbasis Masyarakat.

IV. MEDIA DAN ALAT BANTU

- Bahan tayang
- Modul orientasi
- Laptop/komputer
- LCD *proyektor*

- ATK
- *Flipchart*
- *Banner MVMH*
- Spidol
- *Tools KAP*

V. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Jumlah jam yang digunakan dalam penyampaian materi ini sebanyak 3 JPL (Teori= 2 JPL, Penugasan= 1 JPL, Praktik Lapangan= 0, @45 menit). Dalam memudahkan proses pembelajaran, dilakukan langkah-langkah kegiatan pembelajaran sebagai berikut.

A. Langkah 1 Pengkondisian (5 menit) Langkah pembelajaran:

1. Fasilitator menyapa peserta dengan ramah dan hangat. Apabila belum pernah menyampaikan sesi di kelas, mulailah dengan perkenalan. Perkenalkan diri dengan menyebutkan nama lengkap, instansi tempat bekerja dan judul materi yang akan disampaikan.
2. Menciptakan suasana nyaman dan mendorong kesiapan peserta untuk menerima materi dengan menyepakati proses pembelajaran.
3. Dilanjutkan dengan penyampaian judul materi, deskripsi singkat, tujuan pembelajaran serta ruang lingkup pokok bahasan yang akan dibahas pada sesi ini.

B. Langkah 2

Penyampaian dan pembahasan pokok bahasan tentang Manfaat Pencatatan dalam Pelaksanaan Program Imunisasi dan Peran Kader Sebagai Pencatat Sederhana (10 menit).

Langkah pembelajaran:

1. Fasilitator memberikan kesempatan kepada beberapa orang peserta untuk menyampaikan pengalamannya dalam melakukan pencatatan kegiatan imunisasi.
2. Fasilitator menyampaikan paparan materi Manfaat Pencatatan dalam Pelaksanaan Program Imunisasi dan Peran Kader Sebagai Pencatat Sederhana.
3. Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya atau menyampaikan klarifikasi, selanjutnya fasilitator menyampaikan jawaban atau tanggapan yang sesuai.

C. Langkah 3

Penyampaian dan pembahasan pokok bahasan tentang Pendataan Riil Sasaran Program Imunisasi (15 menit).

Langkah pembelajaran:

1. Fasilitator memberikan kesempatan kepada beberapa orang peserta untuk menyampaikan pengalamannya dalam melakukan pendataan riil sasaran program imunisasi.
2. Fasilitator mencatat semua pendapat peserta di kertas *flipchart*. Selanjutnya merangkum dan menyampaikan paparan materi mengenai Pendataan Riil Sasaran Program Imunisasi dengan menggunakan bahan tayang.
3. Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya atau menyampaikan klarifikasi, selanjutnya fasilitator menyampaikan jawaban atau tanggapan yang sesuai.

D. Langkah 4

Penyampaian dan pembahasan pokok bahasan tentang Pencatatan Hasil Layanan Imunisasi di Posyandu (15 menit).

Langkah pembelajaran:

1. Fasilitator menyampaikan paparan materi mengenai Pencatatan Hasil Layanan Imunisasi di Posyandu dengan menggunakan bahan tayang.
2. Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya atau menyampaikan klarifikasi, selanjutnya fasilitator menyampaikan jawaban atau tanggapan yang sesuai.

E. Langkah 5

Penyampaian dan pembahasan pokok bahasan tentang Pelacakan dan Kunjungan ke Ketua Kelompok Dasa Wisma untuk Menjangkau Bayi dan Baduta yang Belum/Tidak Lengkap Status Imunisasinya (20 menit).

Langkah pembelajaran:

1. Fasilitator menyampaikan paparan materi mengenai Pencatatan Hasil Layanan Imunisasi di Posyandu dengan menggunakan bahan tayang.
2. Fasilitator membagi peserta menjadi beberapa kelompok berdasarkan instrumen pelacakan yang akan dilatihkan.
3. Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya atau menyampaikan klarifikasi, selanjutnya fasilitator menyampaikan jawaban atau tanggapan yang sesuai.

F. Langkah 6

Penyampaian dan pembahasan pokok bahasan tentang Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Berbasis Masyarakat (20 menit).

Langkah pembelajaran:

1. Fasilitator memberikan kesempatan kepada beberapa orang peserta untuk menyampaikan tentang pemahaman mereka mengenai kegiatan surveilans kesehatan berbasis masyarakat dan menyampaikan pengalaman yang mereka miliki.
2. Fasilitator menyampaikan paparan materi mengenai Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Berbasis Masyarakat dengan menggunakan bahan tayang.
3. Fasilitator membagi peserta menjadi beberapa kelompok untuk bersama-sama melakukan latihan penentuan masalah untuk dilakukan survei dan penyusunan *tool* survei sederhana.
4. Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya atau menyampaikan klarifikasi, selanjutnya fasilitator menyampaikan jawaban atau tanggapan yang sesuai.

G. Langkah 7

Penugasan pengisian MVMH:

- Menyiapkan banner MVMH dan kohort/register imunisasi posyandu
- Menuliskan data sasaran bayi dan baduta yang ada di kohort/register imunisasi ke banner MVMH

- Mencatat nama bayi, nama orang tua, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, no. telepon/HP pada kolom yang tersedia dari baris paling atas dilanjutkan baris di bawahnya
- Untuk kolom imunisasi catat tanggal pemberian imunisasi yang sudah diberikan pada kolom jenis antigen yang sesuai
- Catat daftar anak yang akan diimunisasi pada hari pelayanan imunisasi
- Daftar anak imunisasi diumumkan melalui WA/SMS/ pengumuman mesjid, gereja, dan tempat ibadah/umum lainnya
- Catat pemberian imunisasi (tanggal dan bulan) pada kolom imunisasi sesuai jenis antigen/imunisasi yang diberikan pada MVMH
- Menuliskan tanggal imunisasi anak pada banner MVMH.
- Jika sudah mendapatkan semua antigen pada masa bayi, beri tanda bintang (*) pada kolom IDL.
- Jika sudah mendapatkan semua antigen pada masa baduta, beri tanda bintang (*) pada kolom keterangan
- Beri tanda huruf "P" bagi anak yang pindah domisili pada kolom keterangan

H. Langkah 8

Penyampaian rangkuman tentang keseluruhan materi (5 menit). Langkah pembelajaran:

1. Fasilitator mengajak peserta untuk mengungkapkan kembali apa saja materi yang telah dibahas pada sesi ini, mengacu pada tujuan pembelajaran.

2. Fasilitator menutup proses pembelajaran pada sesi ini, dengan mengucapkan terima kasih serta memberikan apresiasi kepada semua peserta yang telah berpartisipasi aktif sehingga tujuan pembelajaran pada sesi ini dapat tercapai.

VI. URAIAN MATERI 3

Terlampir.

VII. REFERENSI

- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi
- Pedoman Praktis Manajemen Program Imunisasi di Puskesmas Tahun 2021. Kementerian Kesehatan.

MATERI 4

KADER SEBAGAI PENGGERAK MASYARAKAT

I. DESKRIPSI SINGKAT

Selain sebagai pencatat sederhana dan penyuluh maka sebagai penggerak kader haruslah memahami dan mampu menjadi seorang penggerak di wilayah kerja Posyandunya. Terlatih dan terampil dalam melaksanakan kegiatan rutin di Posyandu dengan menggerakkan masyarakat sebelum hari buka Posyandu, dan kunjungan rumah yang dilakukan setelah hari buka Posyandu, jika diperlukan. Materi kader sebagai penggerak masyarakat ini disusun untuk membekali kader agar memahami cara-cara penggerakan masyarakat, bagaimana melakukan komunikasi kepada sasaran sehingga mereka mempunyai pemahaman tentang manfaat Posyandu bagi kesehatan ibu dan anak, dan akhirnya termotivasi untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan Posyandu.

II. TUJUAN PEMBELAJARAN

A. Tujuan Pembelajaran Umum

Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu melakukan peran dan fungsinya dalam menggerakkan sasaran datang pada layanan imunisasi rutin.

B. Tujuan Pembelajaran Khusus

Setelah selesai pelatihan ini, peserta orientasi mampu:

1. Memahami cara berkoordinasi dengan Bidan Desa/ Puskesmas, Aparat Desa/Kelurahan dan UKBM setempat.
2. Menjelaskan kegiatan pendekatan kepada tokoh

masyarakat

3. Menjelaskan kegiatan dalam memobilisasi keluarga dan masyarakat berpartisipasi pada program imunisasi
4. Melaksanakan pemberdayaan keluarga dan masyarakat berperan aktif mendukung program imunisasi

III. POKOK BAHASAN

Dalam modul ini akan dibahas pokok bahasan-pokok bahasan sebagai berikut, yaitu:

- A. Peran Kader sebagai Penggerak Program Imunisasi
- B. Langkah dalam Pemberdayaan Masyarakat

IV. MEDIA DAN ALAT BANTU

- Bahan tayang
- Modul orientasi
- Laptop/komputer
- LCD proyektor
- ATK
- *Flipchart*
- Spidol
- Skenario *Role Play*/Simulasi
- Media imunisasi
- Video/film jika ada

V. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Jumlah jam yang digunakan dalam penyampaian materi ini sebanyak 3 JPL (Teori= 1 JPL, Penugasan= 2 JPL, Praktik Lapangan=0, @45 menit). Dalam memudahkan proses pembelajaran, dilakukan langkah-langkah kegiatan pembelajaran sebagai berikut.

A. Langkah 1 Pengkondisian (5 menit) Langkah pembelajaran:

1. Fasilitator menyapa peserta dengan ramah dan hangat. Apabila belum pernah menyampaikan sesi di kelas, mulailah dengan pengenalan. Perkenalkan diri dengan menyebutkan nama lengkap, instansi tempat bekerja dan judul materi yang akan disampaikan.
2. Menciptakan suasana nyaman dan mendorong kesiapan peserta untuk menerima materi dengan menyepakati proses pembelajaran.
3. Dilanjutkan dengan penyampaian judul materi, deskripsi singkat, tujuan pembelajaran serta ruang lingkup pokok bahasan yang akan dibahas pada sesi ini.

B. Langkah 2

Penyampaian pokok bahasan menggunakan bahan tayang/ajar/*ppt* tentang Peran Kader sebagai Penggerak Program Imunisasi dan Langkah dalam Pemberdayaan Masyarakat selama 45 menit.

Langkah Pembelajaran:

1. Fasilitator melakukan curah pendapat dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta untuk mengukur pemahaman peserta tentang perannya sebagai penggerak.
2. Fasilitator mencatat semua pendapat peserta di kertas *flipchart*. Selanjutnya merangkum dan menyampaikan

paparan materi mengenai peran kader sebagai penggerak dalam program imunisasi dilanjutkan materi Langkah pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan bahan tayang.

3. Fasilitator membagi peserta dalam 3 kelompok untuk memberi kesempatan kepada peserta belajar memahami materi selama 10 menit:
 - a. Kelompok 1 bertugas menyusun bahan informasi yang dapat disampaikan pada saat berkesempatan berkoordinasi dengan Bidan Desa/Puskesmas, Aparat Desa/Kelurahan dan UKBM setempat.

No	Masalah Imunisasi berdasarkan data/pencatatan Posyandu	Penyebab masalah: Perilaku dan non perilaku/lingkungan belum datang ke layanan imunisasi	UKBM lain yang terkait dengan masalah Imunisasi
1		a. Perilaku: b. Non perilaku/lingkungan:	
2		a. Perilaku: b. Non perilaku/lingkungan:	
3	Dst.		

Tetapkan prioritas masalah bersama pada saat berkoordinasi dengan petugas puskesmas, kepala desa/lurah, ketua kelembagaan masyarakat (PKK, Karang Taruna, Majelis Taklim, dll.), Kader UKBM/Ketua UKBM lainnya secara musyawarah.

- b. Kelompok 2 bertugas menyusun skenario perencanaan "pendekatan kepada tokoh masyarakat" sebagai

upaya dalam pergerakan peningkatan kehadiran mendapatkan layanan imunisasi rutin

No	Jenis pertemuan/ rapat rutin di desa/kelurahan	Tujuan	Sasaran	Kader UKBM lain	Dukungan yang diharapkan
1.	Rapat bulanan desa/kelurahan				
2.					
3.	 Dst				

No	Kegiatan lokal spesifik/ sosial yang dapat dimanfaatkan	Tujuan	Sasaran	Waktu dan tempat
1.	Pengajian			
2.				

- c. Kelompok 3 bertugas menyusun skenario perencanaan “Mobilisasi keluarga/ masyarakat” agar memanfaatkan Posyandu dan UKBM lain sehingga keluarga dapat memampukan diri dan keluarganya berperilaku hidup sehat khususnya perilaku dalam mengikuti pelayanan imunisasi rutin

Nama KK yang Memiliki Masalah Imunisasi	Jenis Masalah yang Dihadapi	Penyebab Masalah: Perilaku dan Non Perilaku	Kegiatan yang Direncanakan Terhadap Keluarga yang Memiliki Masalah	Pelaksana
1.Keluarga ...		Perilaku: Non perilaku/ lingkungan	Kunjungan rumah	Kader Posyandu, Kader PKK, Pendamping teknis lainnya
2.Kelompok masyarakat				

4. Fasilitator memberikan kesempatan kepada perwakilan kelompok menyajikan hasil diskusi sesuai penugasan, beri kesempatan peserta saling menanggapi hasil diskusi kelompok dan klarifikasi, selanjutnya fasilitator menyampaikan jawaban atau tanggapan yang sesuai.

C. Langkah 3

Penyampaian dan pelaksanaan Langkah Pemberdayaan Masyarakat (6 langkah) selama 80 menit (*Role Play*: dibuat 3 skenario berbeda untuk kel. 1,2,3)

Langkah pembelajaran:

1. Fasilitator menyampaikan secara ringkas Langkah Pemberdayaan Masyarakat (selama 10 menit) yang penting diketahui oleh kader sehingga mampu melaksanakan

perannya sebagai penggerak masyarakat. Kemudian membagi peserta dalam 3 kelompok, tiap kelompok melaksanakan selama 15 menit:

- a. Kelompok 1 bertugas membuat Instrumen SMD sesuai dengan penyebab belum maksimalnya capaian imunisasi di wilayah Posyandu dan melakukan simulasi SMD.

Contoh Instrumen SMD terkait Masalah Imunisasi

Nomor Rumah		Nama KK:	
RT/RW:			
Faktor Penyebab/Faktor Risiko		JAWABAN	
		YA	TIDAK
Perilaku			
- Tidak datang ke Posyandu untuk imunisasi - - -			
Non Perilaku/Lingkungan			
- Jarak Posyandu ke rumah keluarga jauh - Tidak punya ongkos ke Posyandu - Puskesmas jauh - -			
Faktor lain			
Kebijakan - Himbauan agar semua anak bayi dan balita harus diimunisasi tidak ada - -			

Potensi sumber daya masyarakat		
- Kelompok pengajian		
- Kelompok arisan		
- Kelompok		
-		

Simulasi: Tim pendamping teknis mendampingi kader dalam pelaksanaan SMD dengan cara mengunjungi 5 (lima) rumah yang memiliki permasalahan kesehatan tertentu serta melakukan wawancara dan observasi untuk menggali faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyakit/masalah kesehatan. **Instrumen/Kuesioner SMD** yang disusun pada saat pertemuan dipindahkan Kader pada lembaran kertas untuk dibawa ke rumah-rumah untuk diisi dengan jawaban ya atau tidak.

Tim pendamping teknis mendampingi kader melakukan observasi terhadap lingkungan sekitar masyarakat untuk mengetahui potensi yang dapat mendukung (*dapat juga ditanyakan pada saat wawancara*) sebagai pemecahan masalah kesehatan.

b. Kelompok 2 bertugas melaksanakan MMD di tingkat desa/kelurahan

➤ Langkah awal Menyusun Hasil Rekap SMD

Faktor Penyebab/Faktor Risiko	R1	R2	R3	R4	R5	dst	Jumlah	Rangking
Perilaku								
Tidak datang ke Posyandu untuk imunisasi	√	√	√	√	√			
.....	√	-	-	-	-			
.....	√	-	-	-	-			
.....	-	√	√	√	√			

Non Perilaku/Lingkungan							
Jarak Posyandu dari rumah jauh	√	-	-	-	-		
Tidak punya ongkos	-	√					
Puskesmas jauh	√	√					
.....	√	√					
.....	√	√					
Faktor Lain							
.....							
.....							
.....							
Kebijakan							
.....							
.....							
.....							
Potensi Sumber Daya Masyarakat							
.....							
.....							
.....							

*) Catatan:

R1= Rumah Keluarga Pertama; R2= Rumah Keluarga Kedua; R3= Rumah Keluarga Ketiga; dst.

➤ Langkah berikut susunlah agenda acara MMD

CONTOH SUSUNAN ACARA MMD

Tanggal :

Tempat Pelaksanaan : Peserta yang diundang :

Waktu	Kegiatan	Pelaksana	Alat dan Bahan	Peran Kader	PJ
08.00–08.10	Pembukaan	Kepala Desa/Lurah	Draft sambutan	Menyiapkan peralatan yang dibutuhkan	
08.10–08.30	Penyampaian hasil SMD	Kader Masyarakat Desa	Flipchart/ Laporan hasil SMD	Menyiapkan peta desa dan tabel rekapitulasi hasil SMD	
08.30–09.00	Penentuan prioritas penanganan masalah	Fasilitator Pemb Masy Pusk bersama Kepala Desa/Lurah	Flipchart, spidol	Mencatat dan merekap hasil diskusi penentuan prioritas penanganan masalah	
	Penentuan kegiatan dalam rangka mengatasi masalah	Kepala Desa/Lurah	Flipchart, spidol, matriks rencana kegiatan	Mencatat dan merekap hasil diskusi penentuan kegiatan dalam mengatasi masalah	
	Penutup	Kepala Desa			

b. Kelompok 3 bertugas menyusun Perencanaan kegiatan secara partisipatif

No	Jenis Kegiatan	Tujuan	Sasaran	PJ	Pelaksana Yang Terlibat	Kebutuhan Sumber daya	Jadwal	Tempat	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Cara pengisian lihat di buku panduan materi orientasi!

2. Fasilitator memberi kesempatan kepada perwakilan kelompok menyajikan hasil diskusi selama 5-10 menit/kelompok, bersama peserta melihat hasil dari penugasan,anggapi dan bahas bersama serta menjelaskan jawaban yang sesuai.

D. Langkah 5

Penyampaian rangkuman tentang keseluruhan materi (5 menit). Langkah pembelajaran:

1. Fasilitator mengajak peserta untuk mengungkapkan kembali beberapa hal pentingnya memahami penggerakan dan melakukan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung peningkatan kehadiran sasaran mendapatkan layanan imunisasi, mengacu pada tujuan pembelajaran.
2. Fasilitator menutup proses pembelajaran pada sesi ini, dengan mengucapkan terima kasih serta memberikan apresiasi kepada semua peserta yang telah berpartisipasi aktif sehingga tujuan pembelajaran pada sesi ini dapat tercapai.

VI. URAIAN MATERI 4

Terlampir.

VII. REFERENSI

- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- Modul Orientasi Kader dalam Pencegahan *Stunting*, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2019

KEMENKES RI

MATERI 5

KADER SEBAGAI PENYULUH

I. DESKRIPSI SINGKAT

Dalam melakukan penyuluhan, kader kesehatan harus dapat berkomunikasi secara efektif. Komunikasi merupakan proses penyampaian dan penerimaan pesan, informasi, pendapat, perasaan, atau berita di antara dua orang atau lebih, baik secara verbal (melalui ucapan) dan non-verbal (gerak tubuh, suara, raut wajah, dll). Ada berbagai macam metode dalam berkomunikasi, salah satunya adalah Komunikasi Antar Pribadi (KAP). Kader kesehatan yang mampu melakukan komunikasi yang efektif secara otomatis akan dapat memberikan penyuluhan yang lebih baik kepada masyarakat sasarnya dan merupakan kunci keberhasilan bagi program-program kesehatan di wilayah kerjanya.

Pada materi 5 ini, ruang lingkup terkait materi Kader sebagai Penyuluh yang akan dibahas meliputi Konsep Dasar Komunikasi Antar Pribadi dan Komunikasi Antar Pribadi (KAP) pada Pelaksanaan Posyandu dalam Masa Pandemi COVID-19.

II. TUJUAN PEMBELAJARAN

A. Tujuan Pembelajaran Umum

Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menjadi penyuluh dan melakukan komunikasi yang efektif di wilayah kerja Posyandunya.

B. Tujuan Pembelajaran Khusus

Setelah selesai orientasi ini, peserta mampu:

1. Memahami konsep dasar Komunikasi Antar Pribadi
2. Menjelaskan konsep dasar Komunikasi Antar Pribadi
3. Melakukan Komunikasi Antar Pribadi pada pelaksanaan Posyandu dalam masa pandemi COVID-19

III. POKOK BAHASAN

Dalam modul ini akan dibahas pokok bahasan-pokok bahasan sebagai berikut, yaitu:

- A. Konsep Dasar Komunikasi Antar Pribadi (KAP)
- B. Komunikasi Antar Pribadi (KAP) pada Pelaksanaan Posyandu dalam Masa Pandemi COVID-19

IV. MEDIA DAN ALAT BANTU

- Bahan tayang
- Modul orientasi
- Laptop/komputer
- LCD *proyektor*
- ATK
- *Flipchart*
- Spidol
- *Tools* KAP (cetak)

V. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Jumlah jam yang digunakan dalam penyampaian materi ini sebanyak 2 JPL (Teori= 1 JPL, Penugasan= 1 JPL, Praktik Lapangan=0, @45

menit). Dalam memudahkan proses pembelajaran, dilakukan langkah-langkah kegiatan pembelajaran sebagai berikut.

A. Langkah 1 Pengkondisian (5 menit) Langkah pembelajaran:

1. Fasilitator menyapa peserta dengan ramah dan hangat. Apabila belum pernah menyampaikan sesi di kelas, mulailah dengan perkenalan. Perkenalkan diri dengan menyebutkan nama lengkap, instansi tempat bekerja dan judul materi yang akan disampaikan.
2. Menciptakan suasana nyaman dan mendorong kesiapan peserta untuk menerima materi dengan menyepakati proses pembelajaran.
3. Dilanjutkan dengan penyampaian judul materi, deskripsi singkat, tujuan pembelajaran serta ruang lingkup pokok bahasan yang akan dibahas pada sesi ini.

B. Langkah 2

Penyampaian dan pembahasan pokok bahasan tentang Konsep Dasar Komunikasi Antar Pribadi (20 menit).

Langkah Pembelajaran:

1. Fasilitator melakukan curah pendapat dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta untuk mengukur pemahaman peserta tentang Komunikasi Antar Pribadi.
2. Fasilitator mencatat semua pendapat peserta di kertas flipchart. Selanjutnya merangkum dan menyampaikan paparan materi mengenai Komunikasi Antar Pribadi sesuai urutan sub pokok bahasan dengan menggunakan bahan tayang.

3. Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya atau menyampaikan klarifikasi, selanjutnya fasilitator menyampaikan jawaban atau tanggapan yang sesuai.

C. Langkah 3

Penyampaian dan pembahasan pokok bahasan tentang Komunikasi Antar Pribadi (KAP) pada Pelaksanaan Posyandu dalam Masa Pandemi COVID-19 (60 menit).

Langkah pembelajaran:

1. Fasilitator memberikan kesempatan kepada beberapa orang peserta untuk menyampaikan pengalamannya tentang pelaksanaan Posyandu pada masa pandemi COVID-19.
2. Fasilitator mencatat semua pendapat peserta di kertas *flipchart*. Selanjutnya merangkum dan menyampaikan paparan materi mengenai Komunikasi Antar Pribadi (KAP) pada Pelaksanaan Posyandu dalam Masa Pandemi COVID-19 dengan menggunakan bahan tayang.
3. Fasilitator membagi peserta menjadi beberapa kelompok berdasarkan praktik permainan pembelajaran yang akan dilakukan. Permainan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan *tools* KAP.

D. Langkah 4

Penyampaian rangkuman tentang keseluruhan materi (5 menit). Langkah pembelajaran:

1. Fasilitator mengajak peserta untuk mengungkapkan kembali beberapa hal penting tentang Konsep Dasar Komunikasi

Antar Pribadi dan Komunikasi Antar Pribadi (KAP) pada Pelaksanaan Posyandu dalam Masa Pandemi COVID-19 pada sesi ini, mengacu pada tujuan pembelajaran.

2. Fasilitator menutup proses pembelajaran pada sesi ini, dengan mengucapkan terima kasih serta memberikan apresiasi kepada semua peserta yang telah berpartisipasi aktif sehingga tujuan pembelajaran pada sesi ini dapat tercapai.

VI. URAIAN MATERI 5

Terlampir.

VII. REFERENSI

- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- Modul Orientasi Komunikasi Antar Pribadi bagi Pencegahan *Stunting*, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2019
- Modul Orientasi Kader dalam Pencegahan *Stunting*, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2019

KEMENKES RI